



Презентация занятия по теме № 1

Введение в специальность. Цели и задачи ухода за больным. Этико-деонтологические принципы деятельности медицинского работника. Организация медицинской помощи населению. Типы медицинских организаций. Устройство стационара. Устройство, задачи и функции отделений и служб стационара. Приемное отделение больницы. Санитарная обработка. Внутригоспитальная транспортировка больных.



Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Ст. 2 Конституции РФ

Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека

Ст. 7 Конституции РФ

Основные понятия и определения



Этика (лат. ethica, от греч. ethice – обычай) – норма поведения, совокупность моральных правил определенной социальной группы.

Деонтология (греч. deon, deontos – долг, должное, надлежащее; logos – учение) – учение о должном поведении человека.

Деонтология медицинская – совокупность соответствующих морально-этических и правовых принципов и правил, которыми должны руководствоваться медицинские работники в своей деятельности.

Между деонтологией и этикой есть соответствующая внутренняя связь:
деонтология – это раздел этики, нормы которой являются профессиональным долгом всех медицинских работников.

Модели взаимоотношений врача и пациента



Проблемы взаимоотношений медицинских работников и пациентов и лиц его окружающих (родственников, близких, знакомых и др.) – сложная система, в которой медики и пациенты могут находиться в самых разных формах социального взаимодействия.

В настоящее время выделяется *4 основные модели взаимоотношений* врача (или медицинского работника) и пациента:

- ✓ *Инженерная (технологическая) модель*
- ✓ *Пасторская (патерналистская) модель*
- ✓ *Коллегиальная модель*
- ✓ *Контрактная (совещательная) модель*

Инженерная модель



Также её называют технологической моделью, характеризуется отношением врача к пациенту как безличностному организму, в котором возник очаг патологии. В медицине, в рамках этой модели, используется понятие об «отклонении физиологического механизма от положения равновесия», и врач стремится восстановить это равновесие. Показателями служат объективные параметры биохимии, физиологии, клинических исследований.

Пасторская (патерналистская) модель

Модель отношений между врачом и пациентом напоминает отеческое отношение родителя к ребенку или пастора (священника) к прихожанину (pater, лат. – отец). Оба варианта отношений характеризуются покровительством, как и отношение врача к пациенту. Патерналистское отношение мотивировано стремлением помочь человеку (в данном случае страдающему от какого-либо заболевания).

Патернализм (преобладание покровительства) основывается на добродетельных качествах покровительствующей личности: благотворительности, милосердии, справедливости.

Коллегиальная модель



Модель отношений между врачом и пациентом характерна их взаимоотношением (*collega*, лат. – товарищ по должности). Пациент должен получить достаточное количество правдивой информации о своем состоянии здоровья, вариантах лечения, прогнозе развития заболевания. После этого пациент оказывается в состоянии принимать участие в выработке конкретных решений и выступать в роли коллеги лечащего врача. Однако, совпадение уровней знаний медика и больного редко имеет место (только если больной сам врач).

Контрактная модель

Модель взаимоотношений между медиками и пациентами подразумевает, в первую очередь, отношения, построенные на взаимном уважении и доверии, и лишь во вторую очередь имеется в виду формальная сторона отношений, а именно – договор с пациентом, контракт, соглашение, в котором определяются рамки взаимоотношения пациента и врача. При этом моральная сторона отношений в тексте не находит прямого отражения, но она проявляется косвенно.

Именно эта модель в наибольшей степени защищает моральные ценности автономной личности. Ибо для реализации контрактных отношений существенно важны моральные принципы свободы, сохранения достоинства, правдивости, справедливости.



Самым ярким примером законодательного закрепления морально-этических установлений стало включение в Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" **клятвы врача** (ст. 71), которая много веков принималась в качестве морально-нравственного обязательства, а также закрепление в законе таких понятий как:

- ***Статья 6. Приоритет пациента при оказании медицинской помощи;***
- ***Статья 13. Соблюдение врачебной тайны;***
- ***Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников;***
- ***Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями;***



Статья 71

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно **клянусь**:

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, **хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах** независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Общий уход как дисциплина



Уход за больными



- это система лечебных, профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по облегчению состояния пациента, правильному своевременному выполнению лечебных назначений, подготовке и проведению ряда диагностических процедур, грамотному наблюдению за пациентом и мониторингу его состояния, оказанию первой доврачебной помощи и оформлению соответствующей медицинской документации.

Уход



- ▶ **Общий уход** – осуществление общих мероприятий по уходу независимо от характера заболевания (общий осмотр, измерение температуры тела, смена белья и пр.)
- ▶ **Специальный уход** – осуществление специфических мероприятий по уходу в зависимости от диагноза заболевания

Уход за больными



Уход за больными – создание и поддержание санитарно-гигиенической обстановки в палате и дома:

- устройство удобной постели и содержание ее в чистоте;
- гигиеническое содержание больного, оказание ему помощи во время туалета, приема пищи, физиологических и болезненных отправлениях организма;
- выполнение врачебных назначений;
- организацию досуга больного;
- поддержание в больном бодрого настроения

Психо-эмоциональные особенности пациентов



- ▶ легкая возбудимость,
- ▶ раздражительность,
- ▶ вспыльчивость,
- ▶ капризность,
- ▶ подавленность и безучастие

Ятрогенные болезни (ятрогении)



- ▶ заболевания или состояния, обусловленные неосторожными высказываниями или поступками медицинских работников, неблагоприятно воздействовавшими на психику больного.
- ▶ Предупреждению способствуют, с одной стороны, тщательные разъяснительные (психотерапевтические) беседы с больными, а с другой стороны, соблюдение максимальной осторожности в разговоре с больными.
- ▶ **Виды:**
 - ❖ **психогенные ятрогении** (ятропсихогении)
 - ❖ **ятрофармакогении**: следствие медикаментозного воздействия на больного,
 - ❖ **манипуляционные ятрогении**: неблагоприятное воздействие на больного в процессе его обследования
 - ❖ **комбинированные ятрогении**: следствие воздействия нескольких факторов;
 - ❖ **немые ятрогении** – следствие бездействия медицинского работника

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Организация медицинской помощи населению

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ определяется:



Конституцией Российской Федерации

Законодательством Российской Федерации

Постановлениями Правительства России

Нормативными актами и инструктивными материалами Минздрава России, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Организационно-функциональная структура системы здравоохранения РФ



МЗ РФ

Роспотребнадзор

(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

Территориальное
управление
Роспотребнадзора

Росздравнадзор

(Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)

Территориальное
управление
Росздравнадзора

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
(ФОМС)

Территориальное
фонды ОМС
(ТФОМС)

Федеральное
медико-
биологическое
агентство **(ФМБА)**

Органы управления здравоохранения субъектов РФ (МЗ)

Государственные
учреждения
здравоохранения

Муниципальные
учреждения
здравоохранения

Учреждения
здравоохранения
частных форм
собственности

Контрольно-надзорные органы Министерства здравоохранения РФ:



Роспотребнадзор:

осуществляет функции по контролю в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей и потребительского рынка



Росздравнадзор:

осуществляет функции по контролю за соблюдением всеми органами власти, юридическими лицами и ИП обязательных требований в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств.



Федеральное медико-биологическое агентство

Выполняет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, контроль и надзор в сфере донорства крови и ее компонентов, контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в т. ч. при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ населения отдельных территорий.



ФОМС

Для обеспечения ОМС граждан РФ



Статья 41 Конституции Российской Федерации ЗАКРЕПЛЯЕТ

**право гражданина на охрану
здоровья и медицинскую помощь**

Исходя из Основного закона приняты

**«Основы законодательства об охране здоровья граждан Российской
Федерации»,**

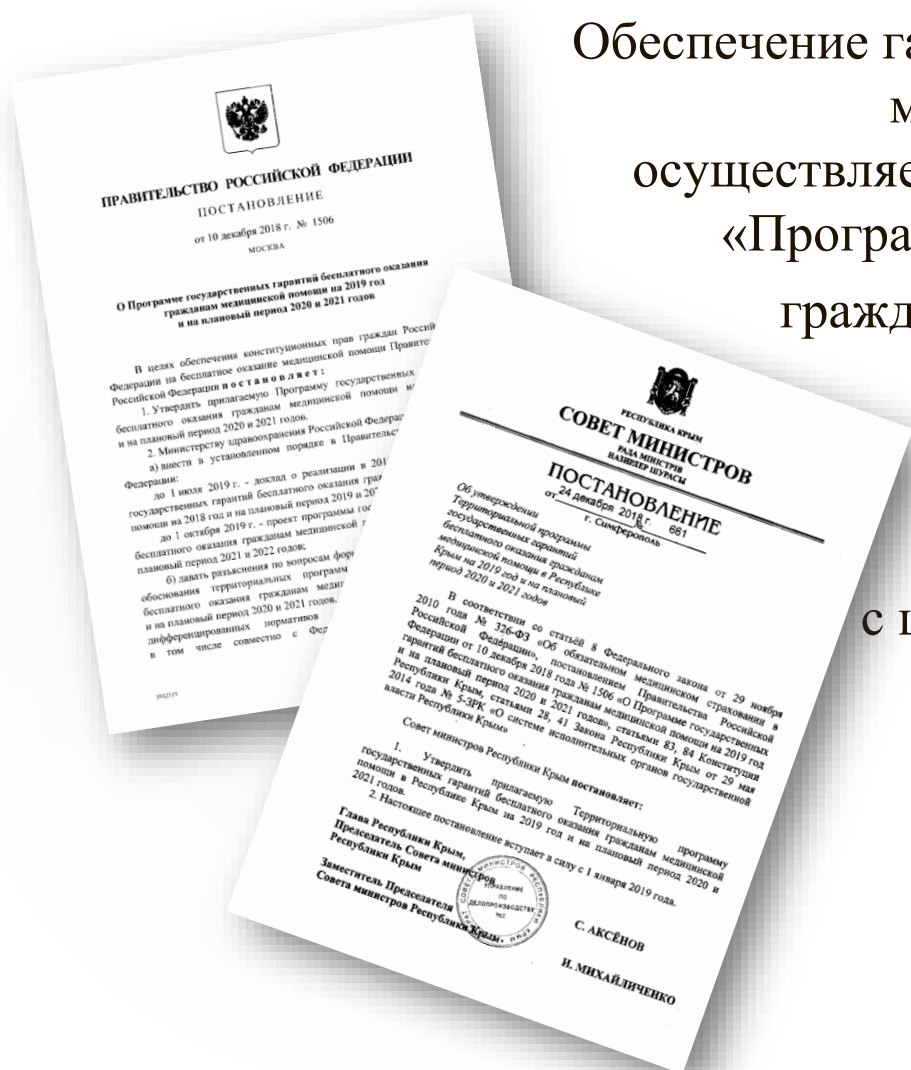
которые регулируют отношения граждан, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, субъектов государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан.

Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи



Обеспечение гарантированной, доступной и бесплатной медицинской помощи всем гражданам РФ осуществляется и контролируется в ходе выполнения «Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи».

Программа ежегодно утверждается Постановлением Правительства РФ с целью реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи



Виды медицинской помощи



- ▶ Квалифицированная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с

Федеральным законом от 21.11.2011 г.

№ 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Формы оказания медицинской помощи



экстренная

- при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих **угрозу жизни пациента**

неотложная

- при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний **без явных признаков угрозы жизни пациента**

плановая

- оказывается при проведении **профилактических мероприятий, заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи**, отсрочка которой на неопределенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью.

Условия оказания медицинской помощи



Вне МО (по месту вызова бригады скорой МП, в т.ч. специализированной, а также транспортном средстве при медицинской эвакуации)

Амбулаторно (в условиях не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, в т.ч. на дому при вызове медицинского работника)

В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения)

Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение)

Виды медицинской помощи



1) Первичная
медико-санитарная помощь



2) Специализированная,
в т. ч. высокотехнологичная МП



3) Скорая, в том числе
скорая специализированная МП



4) Паллиативная МП



Виды медицинской помощи:



Амбулаторная медицинская помощь



Скорая, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная), медицинская помощь



Стационарная медицинская
помощь

Амбулаторная медицинская помощь



предоставляется гражданам



- ⇒ при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения,
- ⇒ при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).

Скорая, в т.ч. специализированная санитарно-авиационная, медицинская помощь



оказывается безотлагательно
гражданам



при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной систем здравоохранения.

Стационарная медицинская помощь



предоставляется
гражданам



в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях в следующих случаях,

- ➔ требующих: круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в т.ч. числе по эпидемическим показаниям;
- ➔ заболевание, в том числе острое;
- ➔ обострение хронической болезни;
- ➔ отравление;
- ➔ травма;
- ➔ патология беременности, роды, аборт;
- ➔ период новорожденности.

Виды, формы и условия оказания медицинской помощи



Виды медицинской помощи	Формы оказания медицинской помощи	Условия оказания медицинской помощи
Первичная медико-санитарная помощь	Плановая и неотложная	Амбулаторно и в дневном стационаре
Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь	Не установлены	Стационарно и в дневном стационаре
Скорая, в т. ч. скорая специализированная, медицинская помощь	Экстренная или неотложная	Амбулаторно, стационарно, вне медицинской организации
Паллиативная медицинская помощь	Не установлены	Амбулаторно и стационарно

Первичная медико-санитарная помощь (ст.33)



основа системы оказания медицинской помощи, включающая мероприятия по

- профилактике
- диагностике и лечению заболеваний и состояний
- медицинской реабилитации
- наблюдению за течением беременности
- формированию здорового образа жизни
- санитарно-гигиеническому просвещению населения

Осуществляется по территориально-участковому принципу (формирование групп по месту жительства, месту работы или учебы, в целях приближения медицинской помощи к гражданам).

Специализированная медицинская ПОМОЩЬ (ст.34)



включает

- профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих специальных методов и сложных медицинских технологий
- медицинскую реабилитацию

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в специализированных амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ст.34)



применение новых, сложных и/или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, включая:

- клеточные технологии
- роботизированную технику
- информационные технологии
- методы генной инженерии

ВМП оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной МП, устанавливаемым МЗ России, и включается в базовую ПГГ



Скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь (ст. 35)



оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, МП медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения **оказывается гражданам бесплатно.**



Паллиативная медицинская помощь (ст. 36)



- (ВОЗ) – комплекс мероприятий, направленных на избавление от боли и облегчение проявлений заболеваний в целях улучшения качества жизни неизлечимых больных (медицина, которая защищает).
- «Это активная, всеобъемлющая помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в терминальных стадиях развития....
- **Главной задачей** паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение психологических и духовных проблем...
- **Целью** паллиативной помощи является достижение возможно наилучшего качества жизни пациентов и членов их семей»



Схема управления системой здравоохранения



Муниципальные органы
власти



- Амбулатория
- Участковая больница
- Станция скорой медицинской помощи
- Поликлиника
- Районная больница, ЦРБ
- Городская больница
- Городская поликлиника
- Больница скорой медицинской помощи
- Станция скорой медицинской помощи
- Родильный дом
- Женская консультация
- Дом сестринского ухода
- Хоспис

Орган управления
здравоохранения



- Специализированное учреждение (диспансер, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, центр)
- Областная, краевая, республиканская больница, окружная больница

Минздравсоцразвития

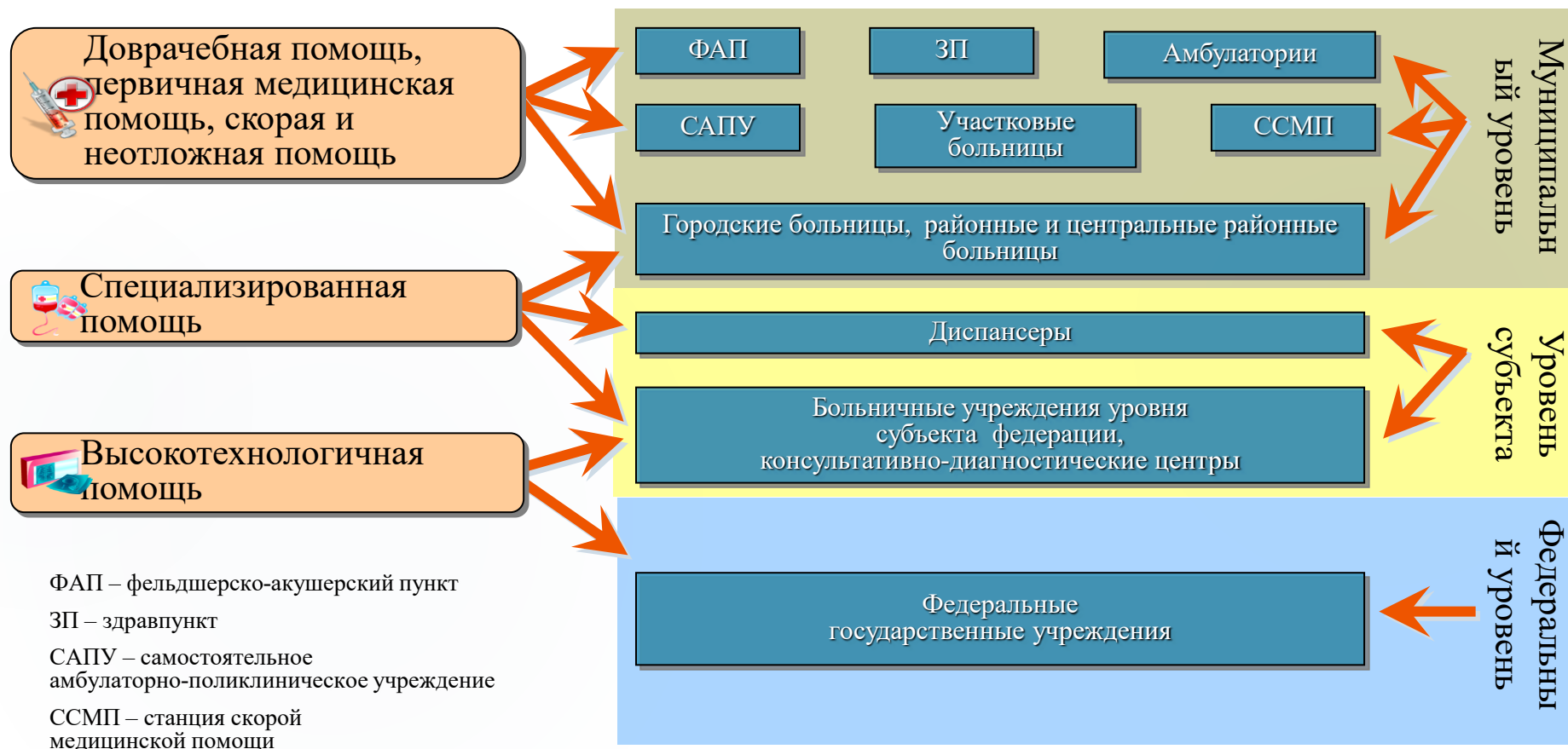


Федеральные государственные учреждения

Классификация учреждений здравоохранения по уровням оказания медицинской помощи



Схема «движения» пациентов по медицинским организациям



Организация амбулаторно-поликлинической медицинской помощи



Первичная медико-санитарная помощь



Доврачебная

Фельдшера, акушеры
и др. мед. работниками
со средним
медицинским
образованием



Врачебная

Врачи-терапевты, врачи-
педиатры,
(в т.ч. участковые) и
врачи общей практики
(семейные врачи)



Специализированная

Врачи-специалисты,
оказывающие
специализированную,
в т. ч. высокотехнологичную,
медицинскую помощь

Первичная медико-санитарная помощь



- неотъемлемая часть национальной системы здравоохранения, ее ядро и главный компонент общего социального и экономического развития общества

ПМСП является первым уровнем контакта между отдельными людьми, семьей, общиной и национальной системой здравоохранения, максимально приближая медицинскую помощь к месту жительства и работы и образуя первый элемент непрерывного процесса охраны здоровья.

- вносит основной вклад в формирование общественного здоровья
- несет наибольшую ответственность за его потерю
- определяет рациональное и эффективное использование ресурсов здравоохранения
- определяет удовлетворенность населения состоянием медицинского обеспечения

Основные принципы оказания ПМСП



Доступность – последовательное и организованное предоставление медицинской помощи, которой может пользоваться все население беспрепятственно в территориальном, финансовом, культурном и функциональном планах

Территориальная доступность – это приемлемость для населения расстояния до медицинского учреждения, времени проезда и стоимости транспортных затрат

Культурная доступность – технические и организационные методы должны отвечать культурному укладу населения

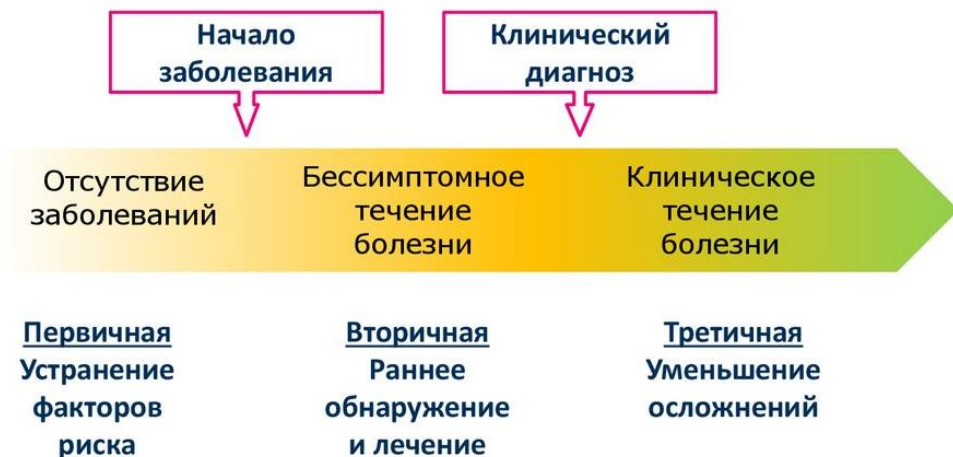
Финансовая доступность – независимо от системы оплаты за медицинские услуги затраты на здравоохранение не должны выходить за пределы возможностей как населения, так и всей страны

Функциональная доступность: требуемый вид медицинской помощи предоставляется тем, кто в ней нуждается, на постоянной основе в любое время силами бригады здравоохранения, должным образом подготовленной для этой работы

Профилактика



- ▶ комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.
- ▶ (ФЗ РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)



Классификация профилактики



- **По уровню воздействия:**
 - Первичная
 - Вторичная
 - Третичная (термин ВОЗ)
- **По степени участия медицинской службы:**
 - Социальная (первичная, третичная)
 - Медицинская (вторичная)
- **По целевым группам**
 - Универсальная профилактика
 - Избирательная профилактика
 - Профилактика по показаниям
- **По отношению к населению**
 - Индивидуальная
 - Групповая (целевые группы)
 - Популяционная (массовая)

Основные методы профилактики:



- ▶ Усиление санитарно-эпидемиологического надзора
- ▶ Диспансеризация (здоровых, лиц с факторами риска развития заболеваний, больных)
- ▶ Целенаправленное санитарное просвещение, гигиеническое воспитание и обучение населения,
- ▶ Пропаганда здорового образа жизни

Диспансеризация - это активное динамическое наблюдение на состоянием здоровья населения, включающее комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий.

Дети – Приказ Минздрава РФ 514н от 10.08.2017 г.

Дети-сироты, опекаемые – Приказ Минздрава РФ 275н от 21.04.2022 г.

Взрослые – Приказ Минздрава РФ 404н от 27.04.2021 г.

Первичная профилактика



- ▶ Меры по снижению влияния вредных факторов на организм человека (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, условий труда, быта и отдыха, уровня психосоциального стресса и других, влияющих на качество жизни), проведение экологического и санитарно-гигиенического контроля.
- ▶ Меры по формированию здорового образа жизни, в том числе:
 - создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний всех категорий населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения;
 - обучение здоровью;
 - меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств;
 - побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления.
- ▶ Меры по предупреждению развития соматических и психических заболеваний и травм, в том числе профессионально обусловленных, несчастных случаев, инвалидизации и смертности от неестественных причин, дорожно-транспортного травматизма и др.
- ▶ Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья факторов, в том числе и поведенческого характера, для принятия мер по их устранению с целью снижения уровня действия факторов риска.
- ▶ Проведение иммунопрофилактики различных групп населения.
- ▶ Оздоровление лиц и групп населения, находящихся под воздействием неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера.

комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности, вызывающих дезадаптацию больных в обществе, снижение трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной смертности.

Вторичная профилактика



- ▶ Целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное и групповое консультирование, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний.
 - ▶ Проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики состояния здоровья, развития заболеваний для определения и проведения соответствующих оздоровительных и лечебных мероприятий.
 - ▶ Проведение курсов профилактического лечения и целевого оздоровления, в том числе лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и иных лечебно-профилактических методик оздоровления, санаторно-курортного лечения.
 - ▶ Проведение медико-психологической адаптации к изменению ситуации в состоянии здоровья, формирование правильного восприятия и отношения к изменившимся возможностям и потребностям организма.
 - ▶ Проведение мероприятий государственного, экономического, медико-социального характера, направленных на снижение уровня влияния модифицируемых факторов риска, сохранение остаточной трудоспособности и возможности к адаптации в социальной среде, создание условий для оптимального обеспечения жизнедеятельности больных и инвалидов (например: производство лечебного питания, реализация архитектурно-планировочных решений и создание соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями и т.д.).
- комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности, вызывающих дезадаптацию больных в обществе, снижение трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной смертности.

Третичная профилактика



- ▶ комплекс медицинских, психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций с целью возможно более полного восстановления социального и профессионального статуса, предупреждения рецидивов и хронизации заболевания

Территориально-участковый принцип организации оказания ПМСП



Приказ МЗиСР РФ от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участка:

- ▶ на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
- ▶ на терапевтическом участке (город) - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше
- ▶ на терапевтическом участке (село) - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше
- ▶ на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
- ▶ на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения;
- ▶ на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения.

Приказ МЗ РФ от 07.03.2018 г. №92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участка:

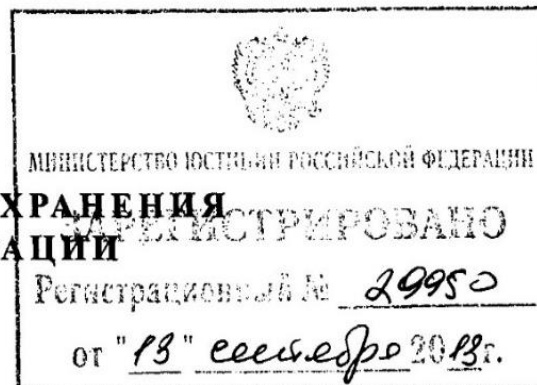
- ▶ на педиатрическом участке - 800 детей
- ▶ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью населения участки могут быть сформированы с меньшей численностью прикрепленных детей с сохранением штатных должностей врачей-педиатров участковых

Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участка:

- ▶ На акушерско-гинекологическом – 2200 женщин



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минздрав России)



П Р И К А З

6 августа 2013 г.

№ *529н*

Москва

Об утверждении номенклатуры медицинских организаций

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить номенклатуру медицинских организаций согласно приложению.

По виду медицинской деятельности



- Лечебно-профилактические медицинские организации;
- Медицинские организации особого типа;
- Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По территориальному принципу



- Федеральные;
- Субъектного уровня (краевые, республиканские, областные, окружные);
- Муниципальные;
- Межрайонные;
- Районные, в том числе центральные;
- Городские, в том числе центральные.

Группы МО стационарного типа по ВОЗ



- восстановительные (диагностика и лечение заболеваний, уход, реабилитация и неотложная помощь);
- профилактические (лечебно-оздоровительная деятельность, профилактика осложнений, хронических и инфекционных заболеваний, инвалидности и др.);
- учебные (подготовка медицинского персонала и его последипломная специализация);
- научно-исследовательские.

Лечебно-профилактические медицинские организации (1)



- ▶ **Больница** (в том числе детская);
- ▶ **Больница скорой медицинской помощи;**
- ▶ **Участковая больница;**
- ▶ **Специализированные больницы** (в том числе по профилю медицинской помощи отдельно для взрослых и для детей), а также специализированные больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения: гинекологическая, гериатрическая, инфекционная, медицинской реабилитации, наркологическая, онкологическая, офтальмологическая, психиатрическая, психоневрологическая, туберкулезная;
- ▶ **Родильный дом;**
- ▶ **Госпиталь** (медицинская организация вооруженных сил стационарного типа, предназначенная для оказания медицинской помощи военнослужащим, ветеранам) – центральный, видов вооруженных сил, окружные, гарнизонные;

Лечебно-профилактические медицинские организации (2)



- ▶ **Медико-санитарная часть**, в том числе центральная (медицинская организация, предназначенная для оказания медицинской помощи работникам промышленности, строительства, транспорта);
- ▶ **Дом (больница) сестринского ухода** (медицинская организация, предназначенная для оказания медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и ухода, но не требующими интенсивного оказания медицинской помощи в условиях стационара);
- ▶ **Хоспис** (медицинская организация, предназначенная для оказания медицинской помощи неизлечимым больным);
- ▶ **Лепрозорий** (медицинская организация, предназначенная для оказания медицинской помощи больным лепрой);
- ▶ **Диспансеры**, в том числе диспансеры государственной и муниципальной систем здравоохранения

Лечебно-профилактические медицинские организации (3)



- ▶ **Поликлиники** (в том числе детские): консультативно-диагностическая, в том числе детская, медицинской реабилитации, психотерапевтическая, стоматологическая, физиотерапевтическая);
- ▶ **Амбулатория**, в том числе врачебная;
- ▶ **Женская консультация**;
- ▶ **Дом ребенка**, в том числе специализированный;
- ▶ **Молочная кухня**;

Лечебно-профилактические медицинские организации (4)



- ▶ **Центры** (в том числе детские): вспомогательных репродуктивных технологий, высоких медицинских технологий, гериатрический, диабетологический, диагностический, здоровья, консультативно-диагностический, клинико-диагностический, лечебного и профилактического питания, лечебно-реабилитационный, лечебной физкультуры и спортивной медицины, мануальной терапии, медицинский, медико-генетический (консультация) и т.д.;
- ▶ **Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови:** станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, центр крови;
- ▶ **Санаторно-курортные организации:** бальнеологическая лечебница, грязелечебница, курортная поликлиника, санаторий, санатории для детей, в том числе для детей с родителями, санаторий-профилакторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

- Медицинские организации, в которых располагаются структурные подразделения **образовательных и научных организаций**, на базе которых осуществляется практическая подготовка медицинских работников (клинические базы), включают в свое наименование слово «клинический».



Медицинские организации особого типа



1. **Центры:** общественного здоровья и медицинской профилактики, медицины катастроф, медицинский мобилизационных резервов «Резерв», медицинский информационно-аналитический, медицинский биофизический, военно-врачебной экспертизы, судебно-медицинской экспертизы;
2. **Бюро:** медико-социальной экспертизы, медицинской статистики, патологоанатомическое, судебно-медицинской экспертизы;
3. **Лаборатории:** клинико-диагностическая, бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза;
4. **Медицинский отряд,** в том числе специального назначения (военного округа, флота);
5. **Отдельный медицинский батальон.**

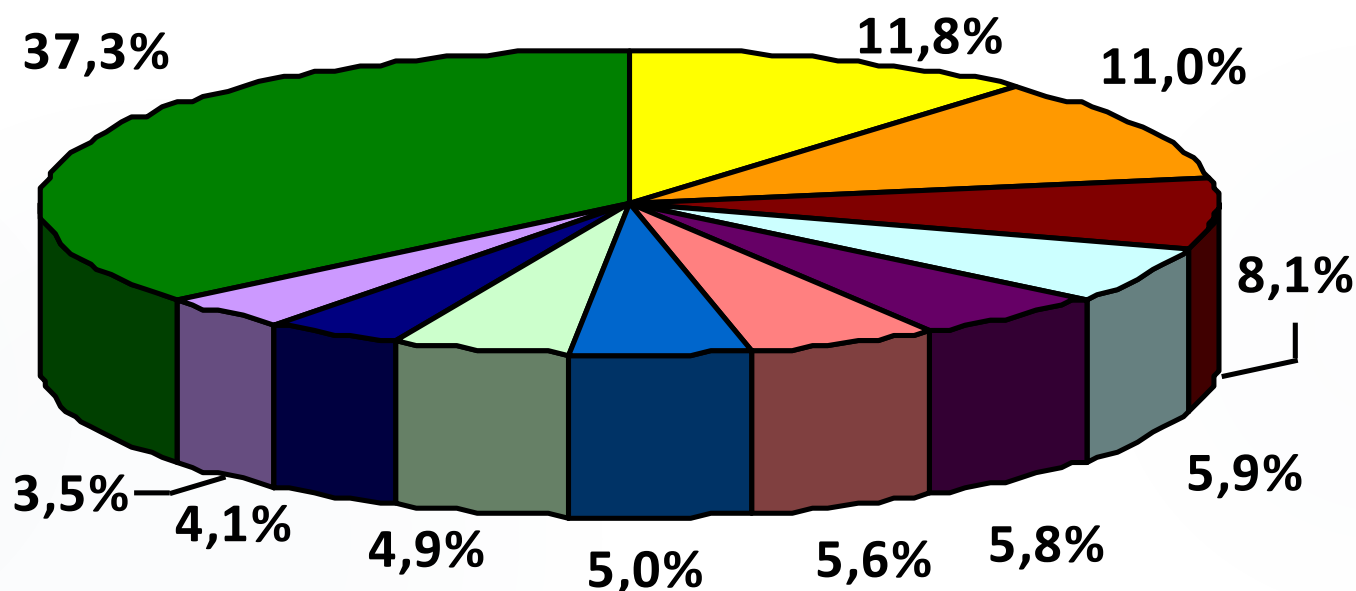
Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



1. **Центры гигиены и эпидемиологии;**
2. **Противочумный центр (станция);**
3. **Дезинфекционный центр (станция);**
4. **Центр гигиенического образования населения;**
5. **Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.**



Структура коечного фонда круглосуточного пребывания



- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| ■ психиатрические | ■ терапевтические | ■ хирургические |
| ■ туберкулезные | ■ неврологические | ■ инфекционные |
| ■ педиатрические | ■ гинекологические | ■ кардиологические |
| ■ травматологические | ■ другие профили | |



Структура и организация работы типовой медицинской организации

Медицинские организации амбулаторно-поликлинического типа

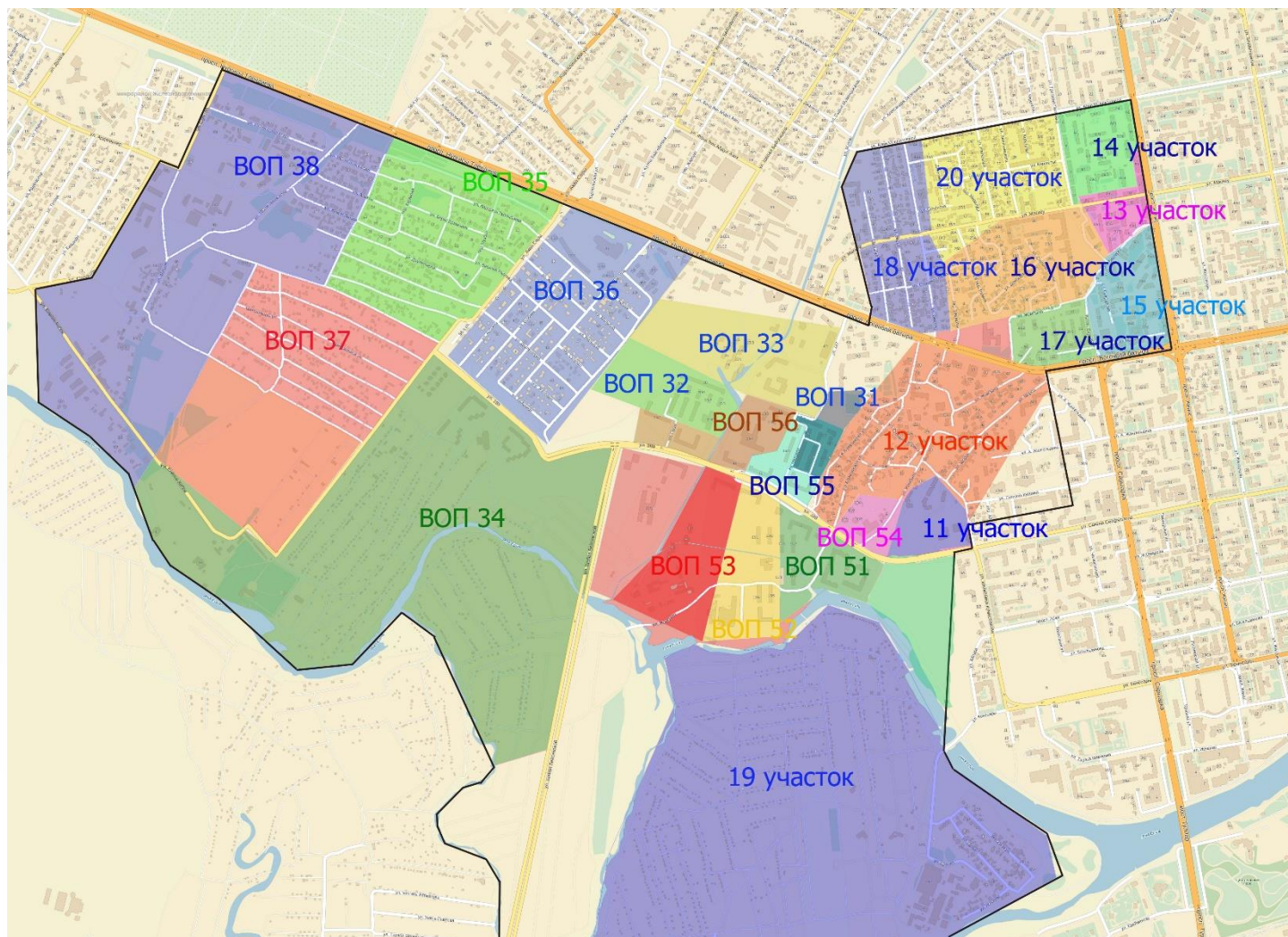


Амбулаторно-поликлиническая помощь — это самый массовый вид медицинской помощи, которую получают практически все пациенты, обращающиеся в медицинские организации.

Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) — это особая группа лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению, как непосредственно в самом учреждении, так и на дому, а также предназначенные для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний.



Пример участкового деления населенного пункта



Николай Александрович
Семашко
1874 – 1949



комплексное самостоятельное учреждение, располагающее кадрами специалистов, оснащением и оборудованием для оказания больным квалифицированной и специализированной медицинской помощи, **как при посещении поликлиники, так и на дому.**

Структура поликлиники и штатная численность устанавливаются главным врачом поликлиники или руководителем медицинской организации, в структуру которой она входит, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых штатных нормативов.

Виды:

- ▶ по организации работы – объединенные со стационаром и не объединенные (самостоятельные);
- ▶ по территориальному признаку – городские и сельские;
- ▶ по профилю – общие для обслуживания взрослого или детского населения, стоматологические и консультативно-диагностические.

Задачи поликлиники



- оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме больным, проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости;
- выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска;
- проведение диспансеризации населения;
- восстановительное лечение и реабилитация;
- клиничко-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;
- организация и оказание паллиативной помощи больным;
- проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, периодические);
- установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации;
- осуществление врачебных консультаций;
- осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе;
- экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности;
- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
- повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием;
- ведение медицинской документации в установленном порядке и представление отчетности;
- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи.

Организационно-штатная структура поликлиники



- ▶ Главный врач
- ▶ Заместители главного врача
- ▶ Заведующие отделениями
- ▶ Отделения профилактики (кабинеты приема врачей, диагностические кабинеты)
- ▶ Лечебные подразделения (отделения специализированной ПМСП, дневной стационар и пр.)
- ▶ Диагностические и вспомогательные подразделения
- ▶ Хозяйственные службы

Структура взрослой поликлиники:



Структура детской поликлиники:



Структурные подразделения поликлиники (1)



- регистратура с картохранилищем;
- отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи;
- кабинет доврачебной помощи;
- отделение общей врачебной (семейной) практики;
- терапевтическое / педиатрическое отделение;
- отделение (кабинет) медицинской профилактики;
- центр здоровья;
- помещения (учебные классы, аудитории) для проведения групповой профилактики (школ здоровья);
- отделения (кабинеты) первичной специализированной медико-санитарной помощи;
- процедурный кабинет;
- смотровой кабинет;
- прививочный кабинет;
- физиотерапевтический кабинет (отделение);
- дневной стационар;
- информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики;
- организационно-методический кабинет (отделение);
- административно-хозяйственные подразделения;

Структурные подразделения поликлиники (2)



- диагностические отделения (кабинеты):
- клинико-диагностическая лаборатория;
- микробиологическая лаборатория;
- отделение (кабинет) функциональной диагностики;
- отделение рентгенодиагностики (рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии легких (флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновский компьютерной томографии и (или) кабинет магнитно-резонансной томографии);
- отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики;
- отделение (кабинет) эндоскопической диагностики.

Амбулатория (врачебная)



- ▶ Врачебная амбулатория организуется для оказания ПМСП в рамках оказания медицинской помощи населению в населенных пунктах с численностью прикрепленного населения **более 2000 человек.**
- ▶ Оказание первичной врачебной медицинской помощи во врачебной амбулатории осуществляется **врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и врачами-специалистами (врач-хирург, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог)** по территориально-участковому принципу.
- ▶ Задачи – схожи с «поликлиникой»

Структура амбулатории



- регистратура;
- процедурная;
- кабинеты врачей;
- кабинет медицинской профилактики;
- комната персонала;
- санузел для персонала;
- санузел для пациентов;
- клиническая лаборатория;
- биохимическая лаборатория;
- санитарная комната.



Дневной стационар



- ▶ является структурным подразделением поликлиники или врачебной амбулатории и организуется для осуществления лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.



Фельдшерско-акушерский пункт



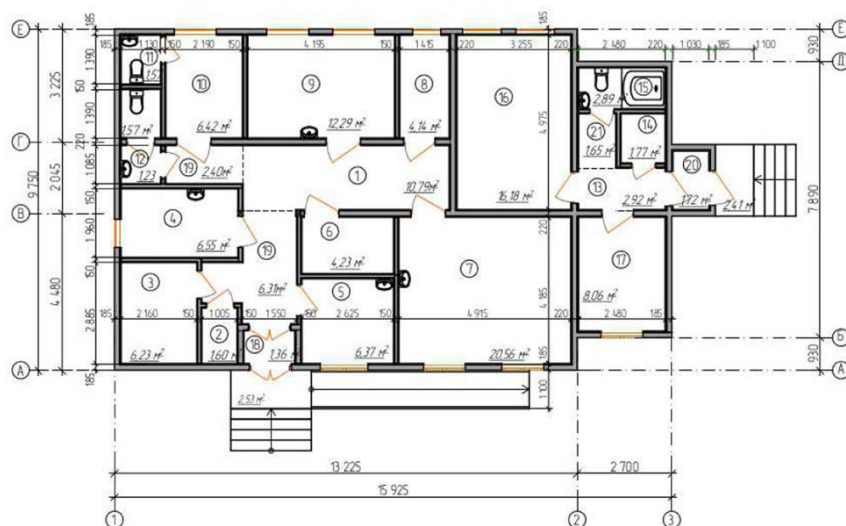
Перспектива



Фасад А-Е



План этажа



Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь, м²	Примечания	№	Наименование помещения	Площадь, м²	Примечания
1	Фельдшерско-акушерский пункт	10.79		13	Присоединение к зданию для медоборудования	2.152	
2	Эксплуатационная	1.60		14	Кладовая	1.177	
3	Тепловая точка	6.23		15	Ванная комната	2.89	
4	Специализированная	4.55		16	Кухня	3.98	
5	Помещение персонала с раздевалкой	4.37		17	Коридор	8.06	
6	Помещение для хранения лекарственных средств	4.23		20	Санитарный	1.172	
7	Помещение для хранения лекарственных средств (лекарственный кабинет)	20.56		21	Коридор	1.165	
8	Помещение для хранения медицинского инвентаря, белья и дезинфицирующих средств	4.44			Итого	93.62	
9	Промышленные помещения, связанные с производством по договору	12.29			Итого по плану	93.62	
10	Кладовая	4.42					
11	Санитарный	1.157					
12	Санитарный	2.80					
18	Коридор	1.136					
19	Коридор	8.71					
	Итого	93.62					

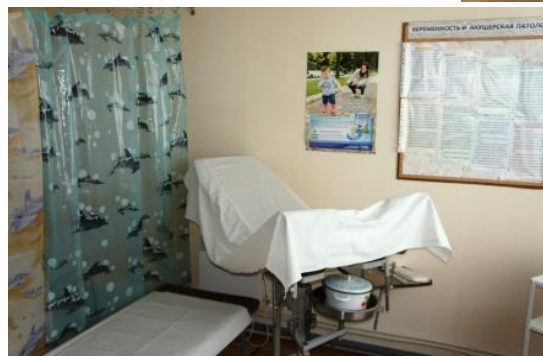
Состав и задачи ФАПа



- ▶ является структурным подразделением медицинской организации (районной или сельской больницы) и осуществляющее под ее руководством комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на определенной территории.
- ▶ ФАП приближает оказание медицинской помощи к сельскому населению.

- ▶ помещения:

1. процедурная;
2. комната фельдшера и акушерки;
3. комната экстренного приема родов;
4. комната временного пребывания пациентов;
5. санузел для персонала;
6. санузел для пациентов;
7. санитарная комната.

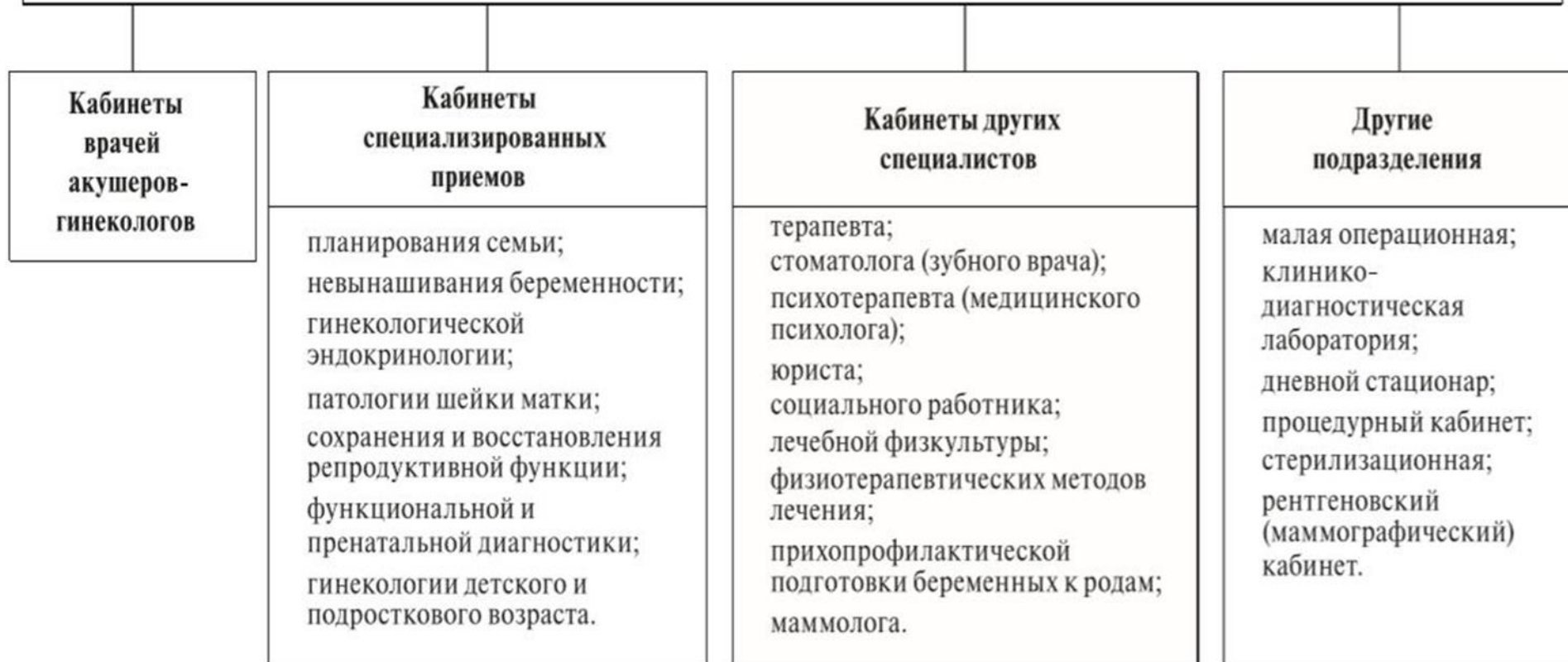
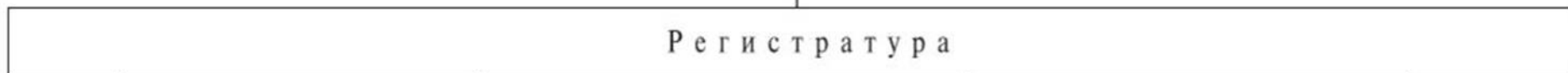
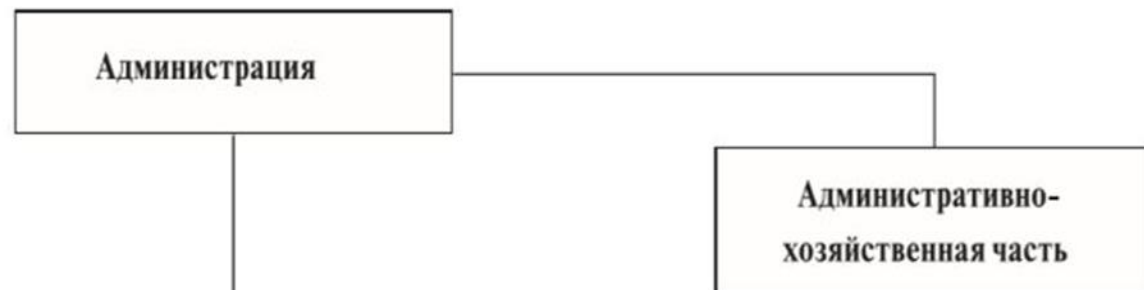


Женская консультация



- Подготовка женщин к беременности и родам, оказание акушерской помощи во время беременности и в послеродовом периоде;
- Оказание помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями;
- Оказание и услуг по планированию семьи, профилактика аборт, ЗППП, внедрение современных методов контрацепции;
- Оказание акушерско-гинекологической помощи в условиях специализированного приема, дневного стационара;
- Оказание социально-правовой помощи в соответствии с законодательством;
- Проведение мероприятий по повышению знаний, санитарной культуры населения в области охраны репродуктивного здоровья;
- Выдача родовых сертификатов...





Центр общей врачебной практики



- ▶ ЦОВП организуют на территории муниципальных районов.
- ▶ Участок врача общей практики формируют из расчета 1500 человек взрослого населения.
- ▶ Участок семейного врача – 1200 человек взрослого и детского населения.



Диспансер



- ▶ медицинская организация, функциями которой являются активное раннее выявление больных определенными группами заболеваний, их регистрация и учет, обследование с целью постановки диагноза, оказание специализированной медицинской помощи, активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья больных определенного профиля, разработка и осуществление необходимых мероприятий по предупреждению заболеваний.
- ▶ Активное проведение медицинских мероприятий по снижению и предупреждению заболеваемости населения распространенными или социально опасными болезнями с помощью диспансерного метода .
- ▶ Организация и контроль за массовыми целевыми осмотрами населения, направленные на выявление той или иной патологии, с использованием специальных методов диагностики и непосредственное участие в этих мероприятиях;
- ▶ Проведение дообследования больных, выявленных в других учреждениях здравоохранения, лечение, последующее наблюдение пациентов, включая противорецидивные мероприятия и медосмотры.

Виды диспансеров:



- противотуберкулезный,
- кардиоревматологический,
- эндокринный,
- офтальмологический,
- онкологический,
- наркологический,
- психоневрологический (ПНД),
- кожно-венерологический (КВД);
- врачебно-физкультурный и др.

Специализированные центры при больницах:

- кардиоревматологический,
- гастроэнтерологический,
- пульмонологический,
- генетический,
- гематологический и др.



Санаторно-курортные организации



(от лат. *sano* «лечу, исцеляю») – медицинская организация, в которой **для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы** (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.



Показания к госпитализации в стационар



1. **Клинические** (состояние, требующее активного (в том числе оперативного) лечения, интенсивной терапии, круглосуточного наблюдения, состояния, требующие активного динамического наблюдения, проведение специальных видов обследования, обследование по направлениям медицинских комиссий военных комиссариатов);
2. **Эпидемиологические** (инфекционные заболевания у проживающих в общежитиях или многонаселенной квартире пациентов, кишечные инфекции в семьях социальных рабочих (продавцы, повара), заболевания средней степени у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также беременных);
3. **Социальные (Социально-бытовые):** отсутствие условий для обеспечения надлежащего ухода и лечения на дому, в том числе материальных; удаленное расположение от медицинских организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Организация стационарной помощи населению

Пути госпитализации пациентов в стационар



- ▶ **машиной СМП**, при возникновении острого или обострении хронического заболевания, несчастного случая или травмы, требующих квалифицированного экстренного лечения в условиях стационара (**экстренная госпитализация**)
- ▶ **по направлению участкового врача** поликлиники или амбулатории в случае неэффективности лечения в домашних условиях (**плановая госпитализация**)
- ▶ **перевод** из других лечебных и профилактических учреждений по договоренности с администрацией больницы
- ▶ **самообращение («самотек»)** - поступление без какого-либо направления лечебно-профилактического учреждения на госпитализацию, если человеку стало плохо на улице, недалеко от больницы, и он самостоятельно обратился в приемное отделение

Виды больниц



- ▶ - участковая;
- ▶ - районная;
- ▶ - городская, в том числе детская;
- ▶ - городская скорой медицинской помощи;
- ▶ - центральная (городская, районная);
- ▶ - областная, в том числе детская (краевая, республиканская, окружная).
- ▶ - восстановительного лечения, в том числе детская;
- ▶ - гинекологическая;
- ▶ - гериатрическая;
- ▶ - инфекционная, в том числе детская;
- ▶ - наркологическая;
- ▶ - онкологическая;
- ▶ - офтальмологическая;
- ▶ - психоневрологическая, в том числе детская;
- ▶ - психиатрическая, в том числе детская;
- ▶ - психиатрическая (стационар) специализированного типа;
- ▶ - психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- ▶ - туберкулезная, в том числе детская;
- ▶ - курортная.

Организация стационара по профилю



- многопрофильные (с несколькими профилями отделений)
- с одним профилем (специализированные больницы и диспансеры):
 - туберкулезные,
 - онкологические,
 - инфекционные,
 - психоневрологические,
 - восстановительного лечения,
 - офтальмологические,
 - кожно-венерологические и др.;



Системы организации стационаров



1. децентрализованная система;
2. централизованно-блочная система;
3. смешанного типа.



Зонирование медицинской организации

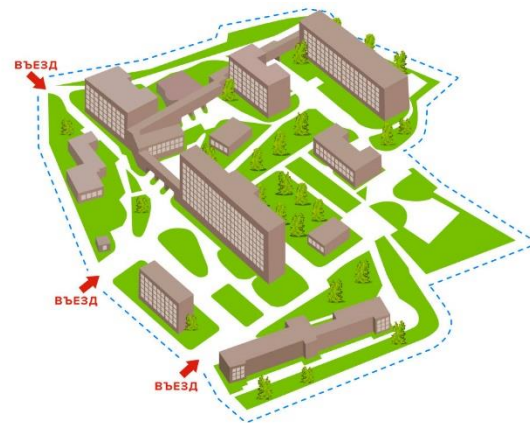


лечебные и лечебно-диагностические здания (лечебные, для неинфекционных больных по профилям (терапевтический, педиатрический и т.д.), для инфекционных больных (туберкулезный, для лечения ВИЧ-инфицированных, для больных с кишечными, воздушно-капельными заболеваниями и т.д.), психосоматические корпуса, диагностические отделения, поликлинические отделения, патологоанатомическое отделение, парк с физкультурными площадками);

хозяйственная зона (пищеблок, прачечная, гараж и др., зоны обеззараживания сточных вод);

зеленая (садово-парковая) зона перед зданиями с лечебными отделениями шириной не менее 30 м.

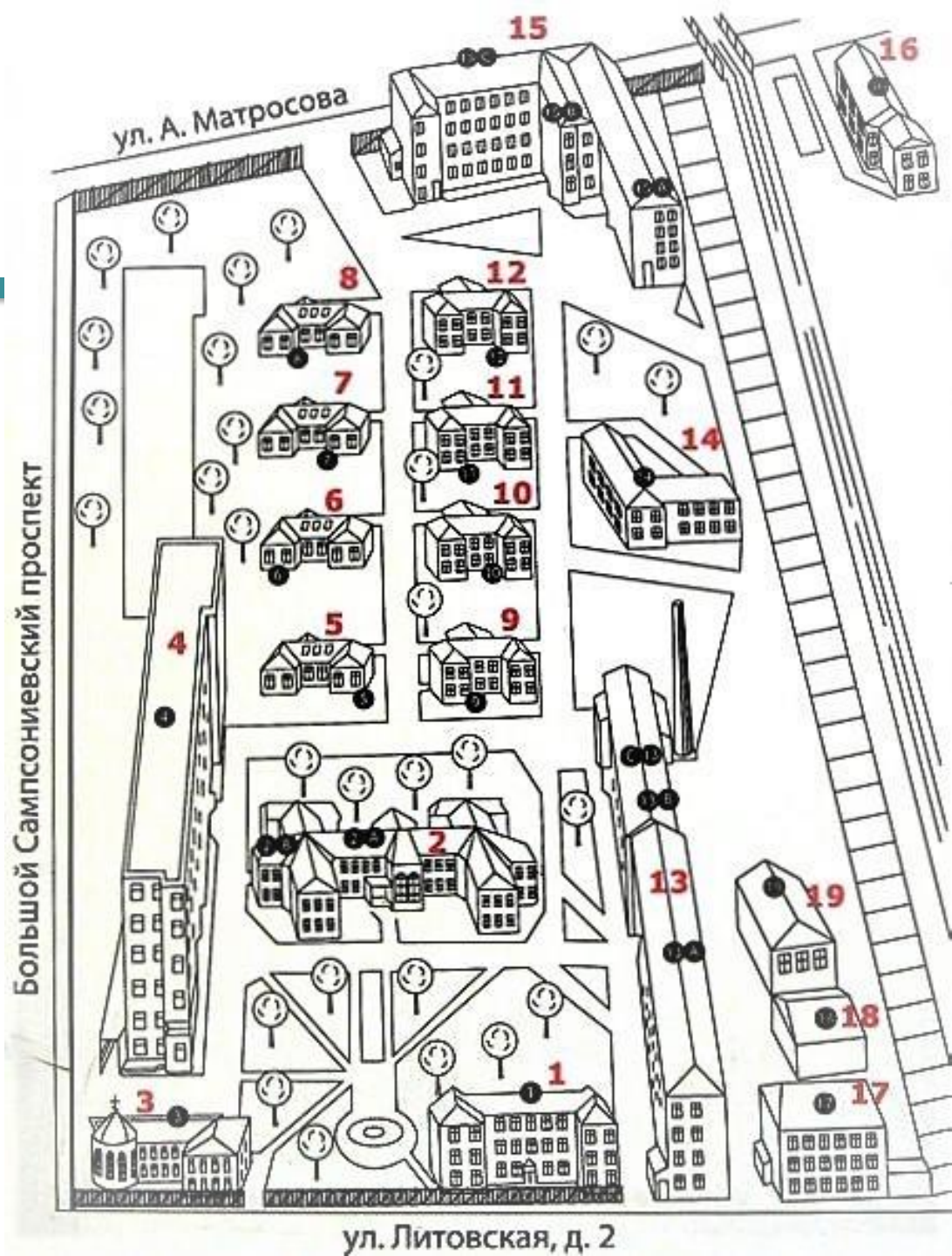
Забор! (1,6 метра во всех МО, 2,5 – в психиатрических МО)



Планирование

медицинской организации

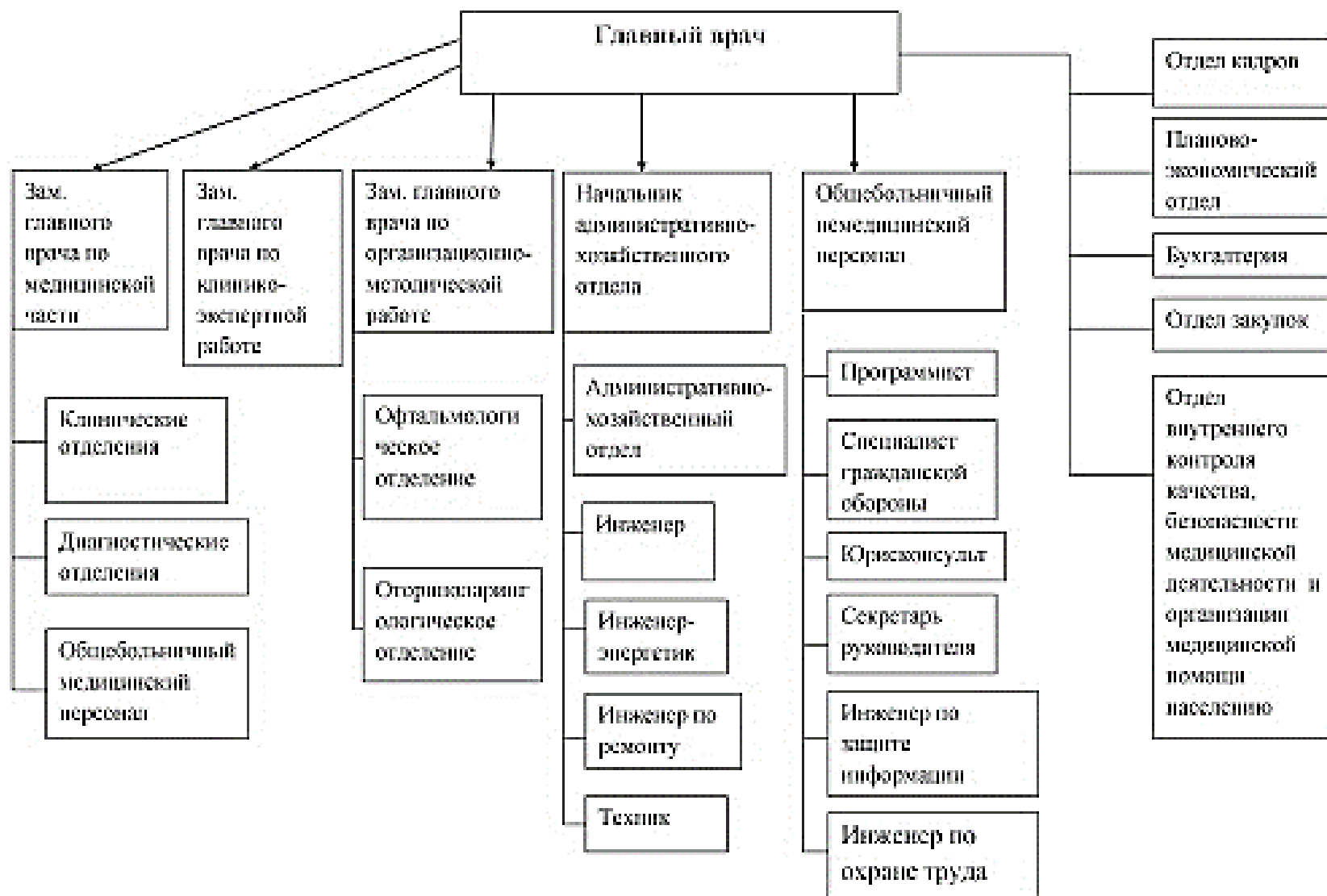
- ▶ Схема многопрофильного стационара смешанного типа на примере клиники СПбГПМУ
- ▶ 1 – административный корпус,
- ▶ 2, 14 – хирургические корпуса,
- ▶ 3 – храм,
- ▶ 4 – клинический корпус (многопрофильный 6-и этажный корпус с приемным отделением) и перинатальный центр,
- ▶ 5, 6, 12, 13, 15, 17 – учебные корпуса,
- ▶ 7, 8 – кожно-венерологическое отделение,
- ▶ 9 – онкологическое отделение,
- ▶ 10 – центральная клиничко-диагностическая лаборатория,
- ▶ 11 – психоневрологическое отделение,
- ▶ 15 – патологоанатомическое отделение,
- ▶ 16 – инфекционное отделение с приемным отделением,
- ▶ 18 – гараж, хозяйственный двор,
- ▶ 19 – архив и отдел камерной и профилактической дезинфекции



Коечная мощность стационара



Категория	Городские больницы	Детские больницы
I	более 1000 коек	300 – 400
II	800 -1000	250 – 300
III	600 – 800	200 – 250
IV	500 – 600	150 – 200
V	300 – 400	100 – 150
VI	250 – 300	75 – 100
VII	100 – 150	50 - 75
VIII	менее 100 коек	менее 50 коек



Структурные подразделения (1). Стационарные отделения



- приемные отделения с помещениями выписки;
- профильные специализированные отделения;
- операционные отделения (блоки);
- отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;
- родовые отделения (блоки);
- дневной стационар.



Структурные подразделения (2). Консультативно-диагностические отделения



- отделения консультативного приема;
- отделения (кабинеты) функциональной диагностики;
- отделения (кабинеты) эндоскопической диагностики;
- отделения (кабинеты) медицинской визуализации;
- лаборатории радионуклидной (радиоизотопной) диагностики;



Структурные подразделения (3). Лечебные отделения



- отделения эфферентной терапии (в том числе гемодиализа);
- отделения гипербарической оксигенации;
- отделения (кабинеты) восстановительного лечения;
- отделения (кабинеты) трудотерапии;
- отделения лучевой терапии;



Структурные подразделения (4). Вспомогательные подразделения



- клинико-диагностические лаборатории;
- отделения переливания крови;
- центральные стерилизационные отделения;
- внутрибольничные аптеки;
- отделения скорой медицинской помощи;
- патологоанатомические отделения;



Структурные подразделения (5). Хозяйственные подразделения



- службы приготовления пищи (кухня);
- прачечные;
- дезинфекционные отделения;
- служебные и бытовые помещения;
- службы снабжения со складскими помещениями;
- службы временного хранения и переработки медицинских отходов;
- инженерные службы по жизнеобеспечению медицинских зданий.
- учебные классы



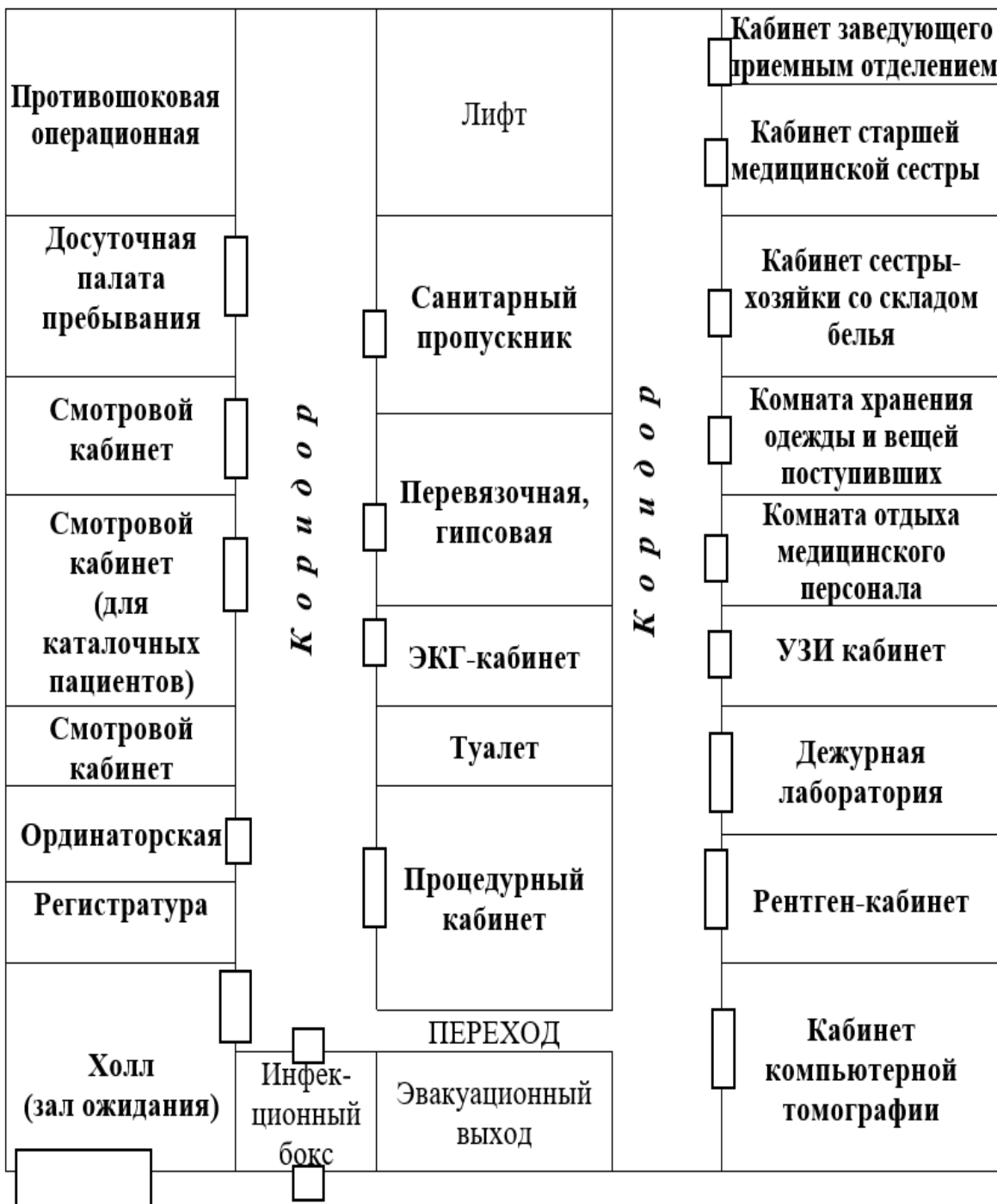


Приемное отделение



Функции:

- ▶ прием, регистрация и медицинская сортировка больных, поступающих в медицинскую организацию;
- ▶ установление предварительного медицинского диагноза на основе осмотра, диагностических исследований и, при необходимости, заключения врачей-консультантов;
- ▶ организация динамического наблюдения за больными с неясными и сомнительными диагнозами в диагностических палатах или изоляционно-диагностических боксах;
- ▶ решение вопроса о необходимости стационарного или амбулаторного лечения;
- ▶ оказание необходимой экстренной и неотложной медицинской помощи;
- ▶ проведение при необходимости санитарной обработки больных, госпитализируемых в неинфекционные отделения;
- ▶ обеспечение мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных заболеваний среди больных и персонала;
- ▶ организация перевода больных, нуждающихся в лечении в других стационарных учреждениях.



1. Зал ожидания.
2. Регистратура.
3. Смотровой.
4. Санитарный.
5. Диагностические кабинеты.
6. Изолятор (бокс).
7. Процедурный кабинет.
8. Операционная (перевязочная).
9. Рентгенологический кабинет.
10. Дежурная лаборатория.
11. Ординаторская
12. Кабинет заведующего приемным отделением.
13. Кабинет старшей медицинской сестры.
14. Кабинет сестры-хозяйки со складом белья.
15. Гардероб.
16. Комната хранения одежды и вещей пациентов, госпитализированных в стационар.
17. Туалетная комната.

Наглядная информация для больных и их родственников:

1. Над приемным отделением – световое табло с надписью «приемное отделение»;
2. Объявление о часах приема плановых больных;
3. Объявление о часах и днях посещения больных родственниками;
4. Правила внутреннего распорядка больницы;
5. График приема главного врача, заместителя главного врача по медицинской части;
6. Перечень продуктов, разрешенных для передачи больным;
7. Четкую маркировку всех помещений приемного отделения;
8. Копия лицензии на право занятия медицинской деятельностью.



Регистратура



Регистрация пациента

ЭМК Пациента

Персональные данные | Контакты | Адрес по прописке

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Пол Новорожденный

Код надёжности идентификации пациента

Страхование ОМС Страхование ДМС

Тип полиса ОМС Серия Номер

Код СМО

Документ

Документ УДЛ Серия Номер

Дата выдачи Место рождения

СНИЛС

Житель ОКATO территории проживания: ОКATO территории прибывания

Социальный статус Категория льготности

Комментарий

Сохранить



Смотровые кабинеты (неинфекционный больной)

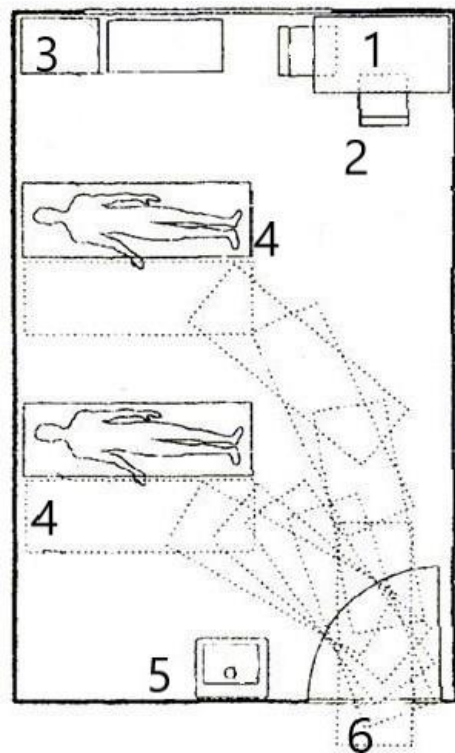
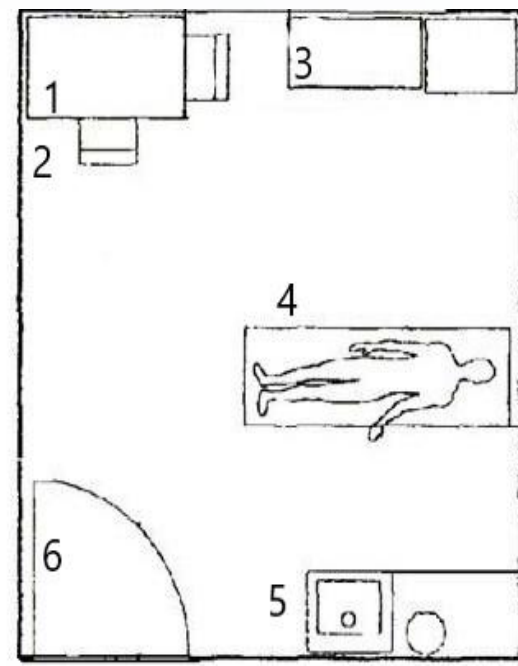
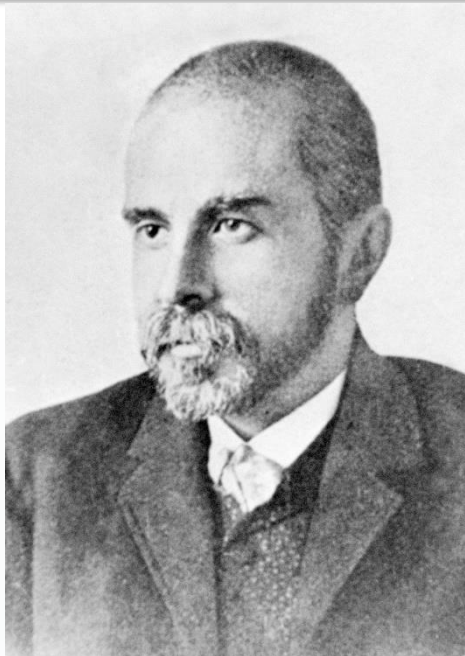


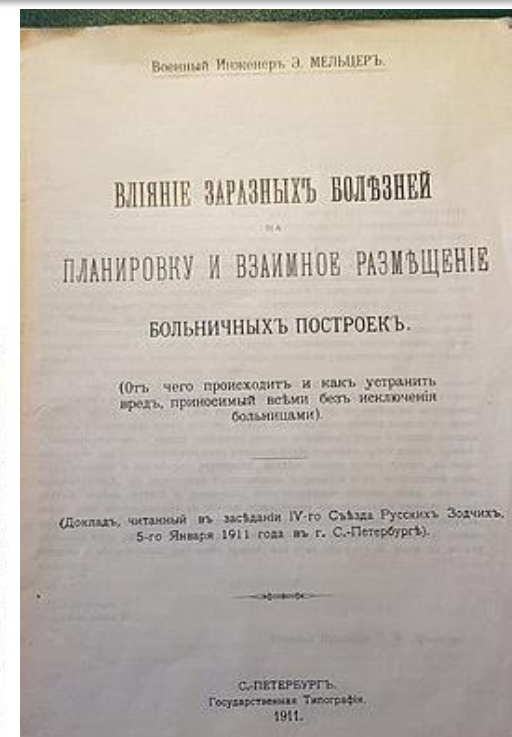
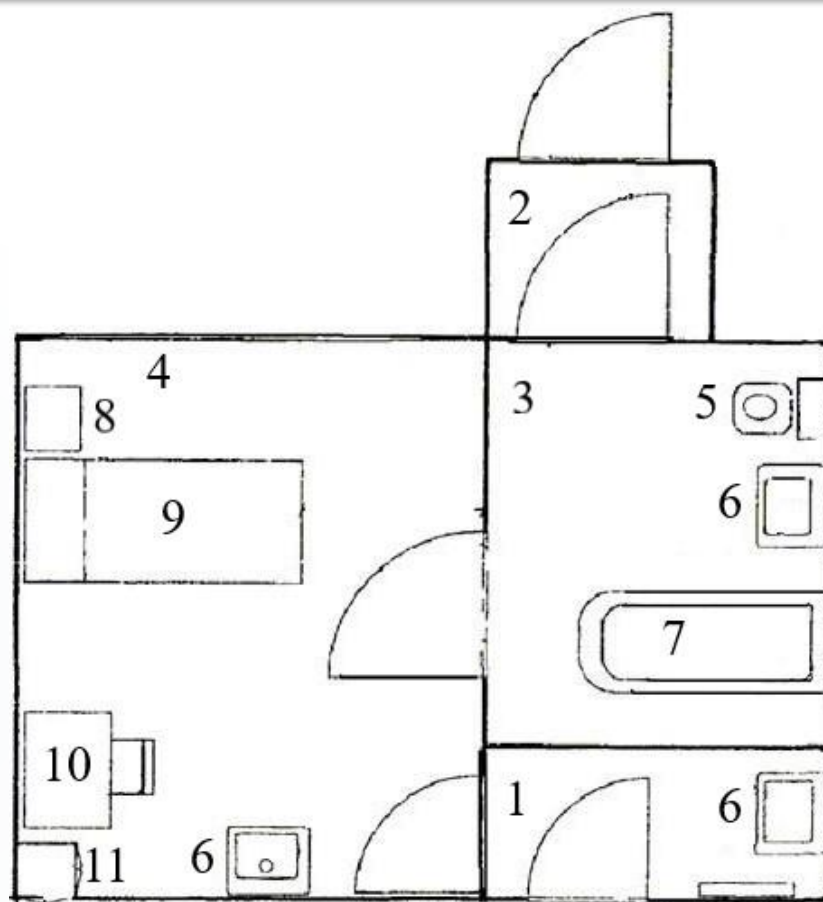
Схема смотровых на 1 кушетку и 2 кушетки
1 – стол для врача, 2 – стул для врача, 3 – шкафы с медицинскими укладками, 4 – кушетка для больного, 5 – раковина с мылом и антисептиком, 6 – вход и выход



Приемно-смотровой фильтр-бокс (Мельцера-Соколова)

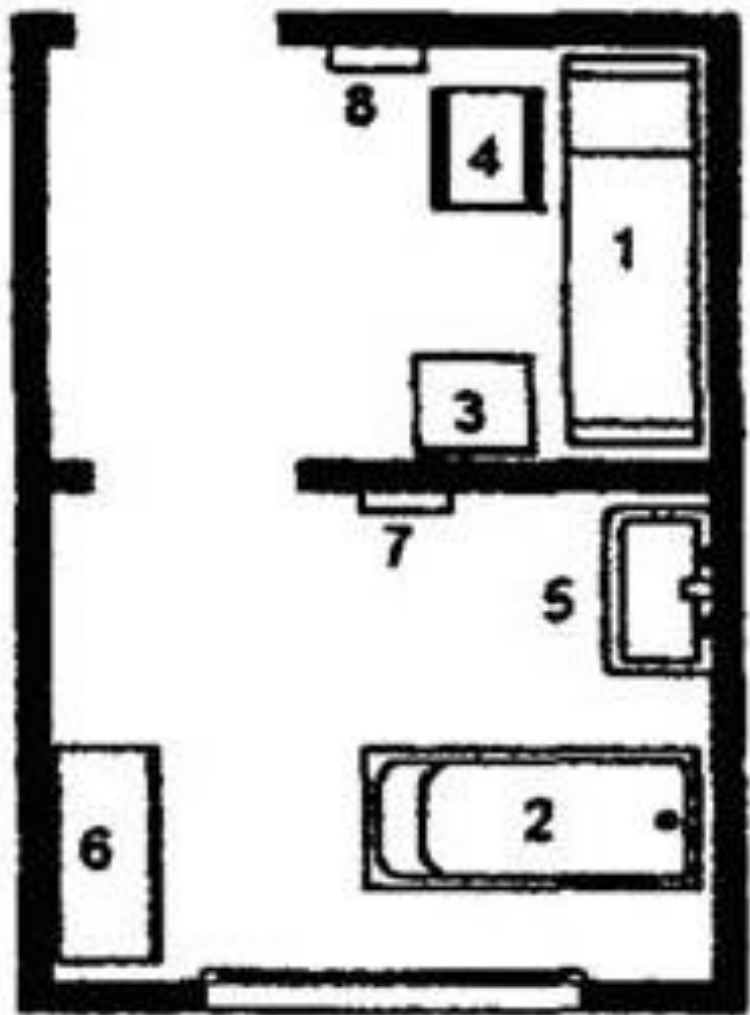


Дмитрий Александрович
Соколов
1861–1915



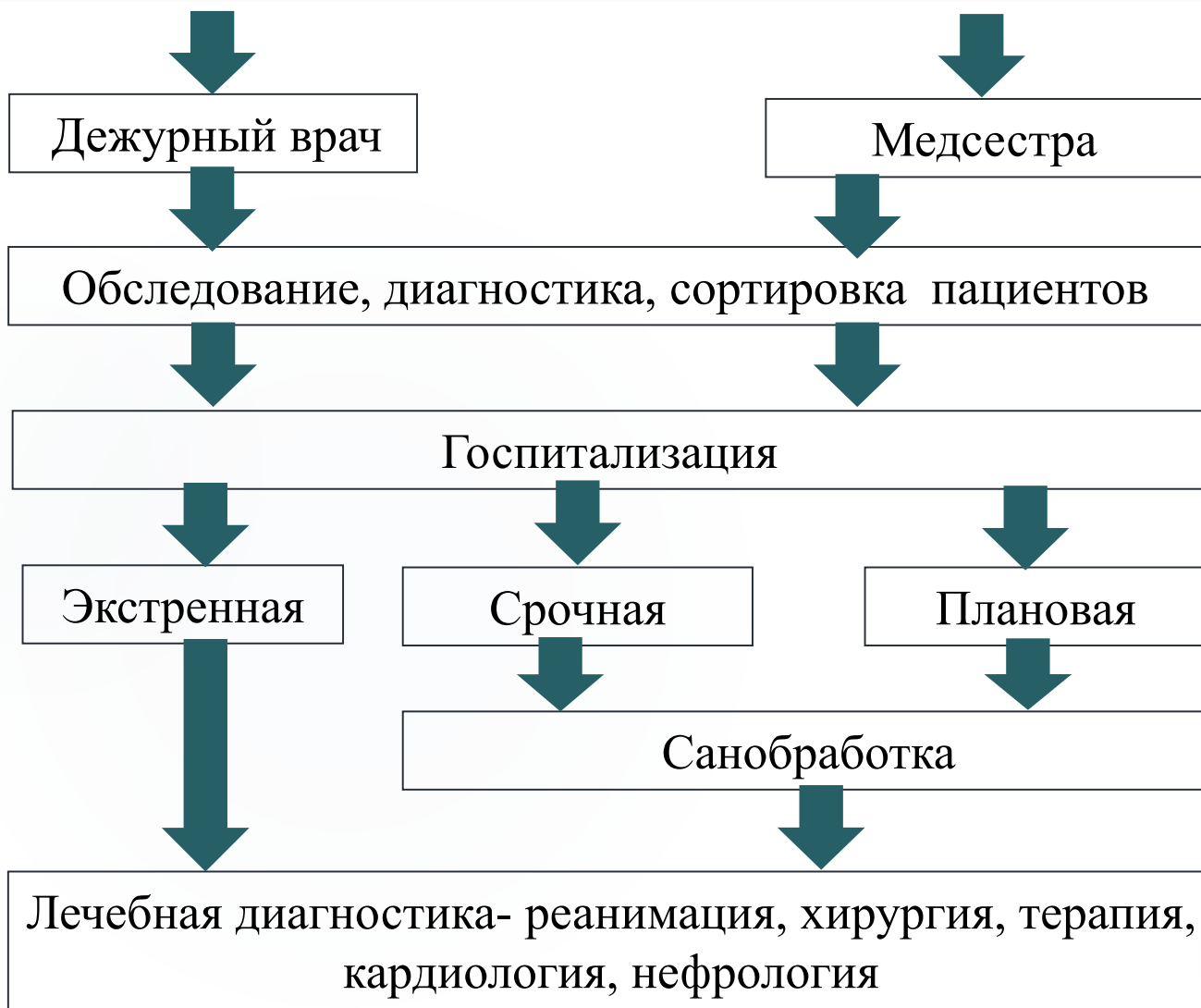
1 - Предбоксник (вход для медицинских работников со стороны коридора стационара); 2 – тамбур; 3 - санитарный пропускник, 4 - палата (смотровой бокс), 5 – унитаз, 6 – раковина, 7 – ванна, 8 - прикроватная тумбочка, 9 – кушетка, 10 стол и стул для врача, 11 - шкаф с медицинской документацией

Санитарный пропускник



1. Кушетка медицинская
2. Ванна прямобортная с душевой системой
3. Тумба прикроватная
4. Табурет
5. Умывальник
6. Шкаф для медико-хозяйственных принадлежностей
7. Полотенцесушитель
8. Вешалка на 2 крючка
9. Подъемник для перемещения больного в ванну
10. Каталка
11. Душ

Этапы приема пациента в стационар



Плановая госпитализация



- Паспорт
- Медицинский полис
- СНИЛС

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

(наименование медицинского учреждения)

(адрес)

Код ОГРН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 5
к Приказу Минздравсоцразвития РФ
от 22.11.2004 № 255

Медицинская документация
Форма № 057/у-04
утверждена Приказом Минздравсоцразвития России
от 22.11.2004 № 255

НАПРАВЛЕНИЕ

на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию
(нужное подчеркнуть)

(наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент)

1. Номер страхового полиса ОМС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Код льготы

--	--	--

3. Фамилия, имя, отчество

4. Дата рождения

5. Адрес постоянного места жительства

6. Место работы, должность

7. Код диагноза по МКБ

--	--	--	--	--

8. Обоснование направления

Должность медицинского работника, направившего больного

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий отделением

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ ” Г.

М.П.



Российская Федерация
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

№ 023-244-237-03

Ф.И.О. СОКОЛОВ
ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ

Дата и место рождения 16 октября 1949 г.
ЛЕНИНГРАД

В обязанности медицинской сестры приемного отделения входит:



- ▶ готовить рабочее место, получать от старшей сестры всё необходимое для процедурного кабинета;
- ▶ ознакомиться с направлением пациента и сопровождать его в кабинет дежурного врача;
- ▶ выслушать жалобы пациента, поступившего «самотёком» и направить его к дежурному врачу;
- ▶ измерять поступившим пациентам температуру тела;
- ▶ заполнять паспортную часть карты стационарного больного, чётко вести медицинскую документацию;
- ▶ осматривать пациента на педикулёз;
- ▶ выполнять назначения врача;
- ▶ следить за состоянием пациентов, находящихся в изоляторе, и своевременно выполнять указания врача по их обследованию и лечению;
- ▶ осуществлять по указанию врача вызов консультантов и лаборантов;
- ▶ своевременно передавать телефонограммы, активные вызовы в ЦСЭН при выявленных инфекционных заболеваниях и педикулёзе;
- ▶ уметь оказать неотложную помощь, в т. ч. и реанимационную, доврачебную помощь;
- ▶ осуществлять взятие мочи, кала, рвотных масс и промывных под для лабораторного исследования;
- ▶ руководить работой младшего медицинского персонала;
- ▶ работать над повышением деловой квалификации.

Документация приемного отделения



▶ **Журнал учета приема больных (госпитализации) –форма 001/у.** В журнале отмечают ФИО пациента, год рождения (кол-во полных лет), дату время поступления, пол, подробный адрес места жительства и регистрации, номер дом., моб тел, ФИО супруга/супруги, место работы, профессия, должность, канал госпитализации –откуда доставлен, диагноз, и в какое отделение пациент направлен. *Обязательно: указывают результаты осмотра на педикулез. Если есть документы- паспорт серия/ номер и страх. полис.*

▶ **Журнал плановой госпитализации.** В некоторых стационарах этот журнал объединен с журналом экстренной госпитализации. Запись о пациенте та же.

▶ **Журнал отказов от госпитализации.**

• **Медицинская карта стационарного больного форма 003/у.** заполнение титульного листа.

• **Статистическая карта – форма 006/у.**

- количество поступивших пациентов;
- количество выписавшихся пациентов;
- количество умерших пациентов;
- диагноз при поступлении и диагноз при выписке;
- возраст, пол, социальный статус пациентов;
- является ли пациент городским или сельским жителем.

Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 августа 2022 г. N 530н



УЧЕТА ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ И ОТКАЗОВ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Окончен " " 20 г.

[illegible]



Диагноз заболевания (состояния), поставленный направившей медицинской организацией, выездной бригадой скорой медицинской помощи (код по МКБ) ¹	Причина и обстоятельства травмы (в том числе при дорожно-транспортных происшествиях), отравления (код по МКБ)	Факт употребления алкоголя и иных психоактивных веществ, установление наличия или отсутствия признаков состояния опьянения при поступлении пациента в медицинскую организацию, дата и время взятия пробы и результаты лабораторных исследований	Отделение медицинской организации, в которое направлен пациент	Исход госпитализации (выписан, переведен в другую медицинскую организацию, умер), дата и время исхода, наименование медицинской организации, куда переведен пациент	Дата и время сообщения законному представителю, иному лицу или медицинской организации, направившей пациента, о госпитализации (отказе в госпитализации) пациента, ее исходе	В случае отказа в госпитализации в стационар, дневной стационар		Дополнительные сведения
						Причина отказа в госпитализации (отказался пациент, отсутствие показаний, помощь оказана в приемном отделении медицинской организации, направлен в другую медицинскую организацию, иная причина)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, зафиксировавшего причину отказа в госпитализации	
15	16	17	18	19	20	21	22	23



**МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА,
ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА**

N _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента: _____
Дата рождения: "___" _____ 20__ г. Пол: мужской - 1, женский - 2

Поступил в стационар - 1, в дневной стационар - 2 (указать): _____
Дата и время поступления: "___" _____ 20__ г. время: ____ час. ____ мин.
Поступил через _____ часов после начала заболевания, получения травмы, отравления.

Направлен в стационар (дневной стационар): поликлиникой - 1, выездной бригадой скорой медицинской помощи - 2, полицией - 3, обратился самостоятельно - 4, другое - 5 (указать) _____
Наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), направившей пациента: _____

Номер и дата направления: _____ от "___" _____ 20__ г.
Поступил в стационар (дневной стационар) для оказания медицинской помощи в текущем году: по поводу основного заболевания, указанного в диагнозе при поступлении: впервые - 1, повторно - 2.

Форма оказания медицинской помощи: плановая - 1. экстренная - 2.
Наименование отделения: _____ профиль коек _____ палата N _____
Переведен в отделение: _____ профиль коек _____ палата N _____
Дата и время перевода: "___" _____ 20__ г. время: ____ час. ____ мин.

Выписан: "___" _____ 20__ г. время: ____ час. ____ мин.
Количество дней нахождения в медицинской организации: _____

Диагноз при направлении: _____ код по МКБ _____

Предварительный диагноз (диагноз при поступлении): _____
Дата и время установления диагноза при поступлении: "___" _____ 20__ г. время: ____ час. ____ мин.
Основное заболевание _____ код по МКБ _____

Осложнения основного заболевания _____ код по МКБ _____

Внешняя причина при травмах, отравлениях _____ код по МКБ _____

Сопутствующие заболевания _____ код по МКБ _____

Дополнительные сведения о заболевании _____



В анамнезе: туберкулез _____ ВИЧ-инфекция _____ вирусные гепатиты _____ сифилис _____ COVID-19 _____
Осмотр на педикулез, чесотку: да - 1, нет - 2, результат осмотра: _____
Аллергические реакции на лекарственные препараты, пищевая аллергия или иные виды непереносимости в анамнезе, с указанием типа и вида аллергической реакции: _____

Трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов (год, осложнения, реакции): _____

Группа крови _____ резус-принадлежность _____ антиген K1 системы Kell _____
иные сведения групповой принадлежности крови (при наличии) _____
Диагноз клинический, установленный в стационаре, дневном стационаре: _____
Дата и время установления клинического диагноза: "___" _____ 20__ г. время: ____ час. ____ мин.
Основное заболевание _____ код по МКБ _____

Осложнения основного заболевания _____ код по МКБ _____

Внешняя причина при травмах, отравлениях _____ код по МКБ _____

Сопутствующие заболевания _____ код по МКБ _____

Дополнительные сведения о заболевании _____

Проведенные оперативные вмешательства (операции): _____

Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____

Министерство здравоохранения
СССР

наименование учреждения _____

Медицинская документация
Форма N 058/у
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80 N 1030

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на
прививку

1. Диагноз _____
подтвержден лабораторно: да, нет (подчеркнуть)

2. Фамилия, имя, отчество _____
3. Пол _____

4. Возраст (для детей до 14 лет - дата рождения) _____

5. Адрес, населенный пункт _____ район
улица _____ дом N _____ кв. N _____
(индивидуальная, коммунальная, общежитие - вписать)

6. Наименование и адрес места работы (учебы, детского учреждения)

7. Даты:
заболевания _____
первичного обращения (выявления) _____
установления диагноза _____
последующего посещения детского учреждения, школы

госпитализации _____



Экстренное извещение в ТУРПН –
форма 058/у.

В извещении отмечают ФИО пациента, возраст, адрес места жительства и работы, номера телефонов, список людей, контактирующих с пациентом, их домашние и рабочие адреса, номера телефонов и мероприятия, проведенные с пациентом и контактными.

8. Место госпитализации _____

9. Если отравление – указать, где оно произошло, чем отравлен пострадавший _____

10. Проведенные первичные противоэпидемические мероприятия и дополнительные сведения

11. Дата и час первичной сигнализации (по телефону и пр.) в СЭС _____

Фамилия сообщившего _____

Кто принял сообщение _____

12. Дата и час отсылки извещения _____

Подпись пославшего извещение _____

Регистрационный № _____ в журнале ф. № _____
санэпидстанции.

Подпись получившего извещение _____



Журнал регистрации педикулеза – форма 060/у. В графе «Дата заболевания» указывают дату выявления педикулеза, графе «Диагноз, дата его установления» - диагноз заболевания.

В графе «Изменённый, уточненный диагноз, дата его установления» указывают вид педикулеза – головной, платяной, смешанный и выявленные стадии развития:

Яйца (гниды);

Насекомые.

В графе «Лабораторное обследование и его результаты» указывают дату, вид санитарной обработки и результаты предыдущего контроля эффективности обработки.

Журнал телефонограмм – указывают текст, дату, время передачи, кем отправлена, кем принята



№ п/п	Дата и время передачи телефоно- граммы	Номер телефоно- граммы	Должность, ФИО, от имени кого подается телефоно- грамма	Текст телефоно- граммы	Кто передал, ФИО, должность, номер телефона	Кто принял, ФИО, должность, номер телефона
1	2	3	4	5	6	7

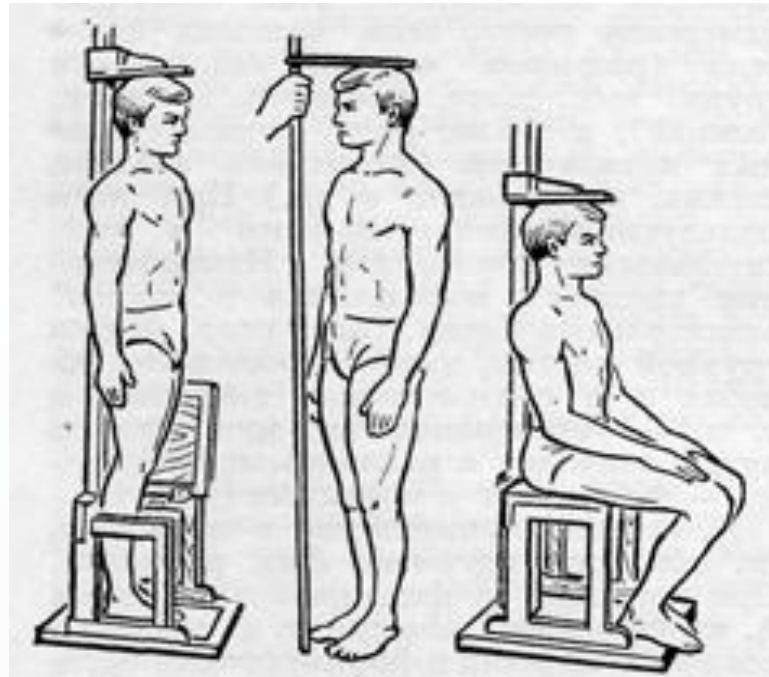
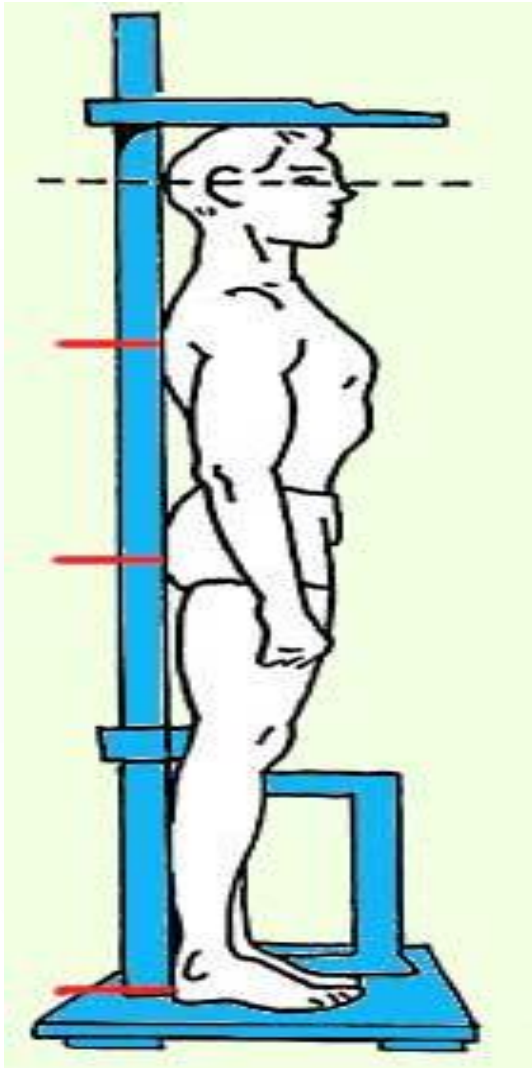


Антропометрия

Соматометрия



Измерение длины / роста



**Точность
измерений –
0,5 см**

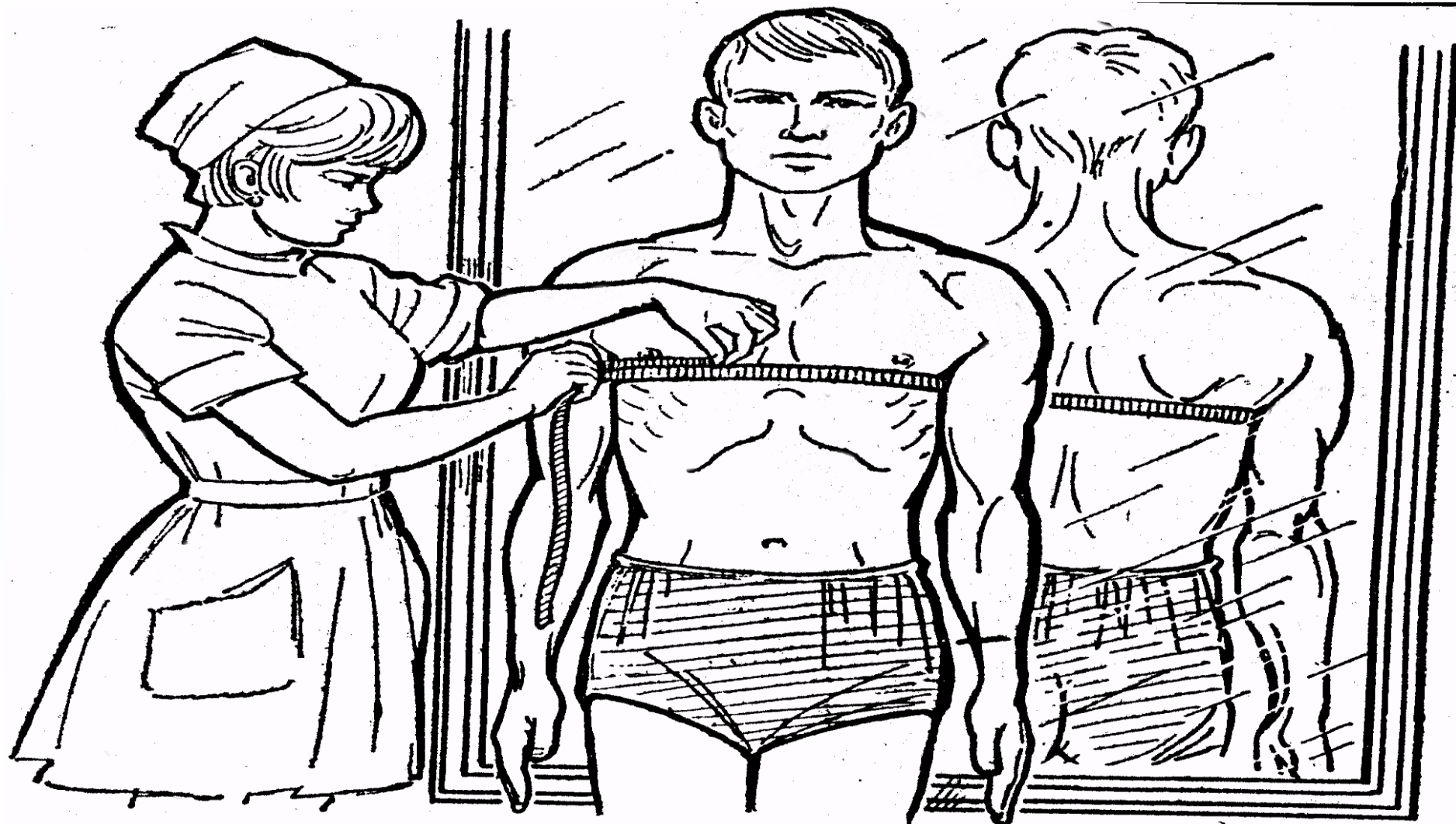
Голова устанавливается так: наружный угол глаза и козелок уха находятся на одной горизонтальной прямой, параллельной плоскости пола (классика);

- наружный угол глаза и верхний край прикрепления ушной раковины к височной области находятся на одной горизонтальной прямой, параллельной плоскости пола (реальность).

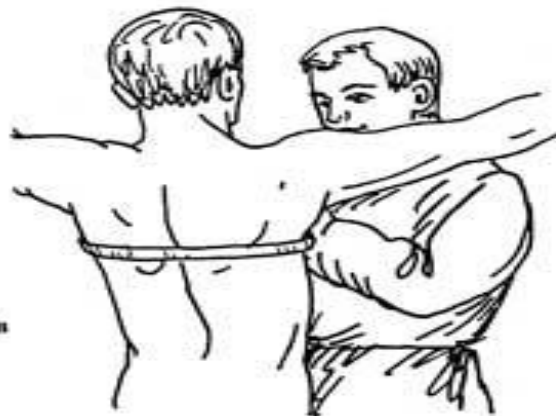
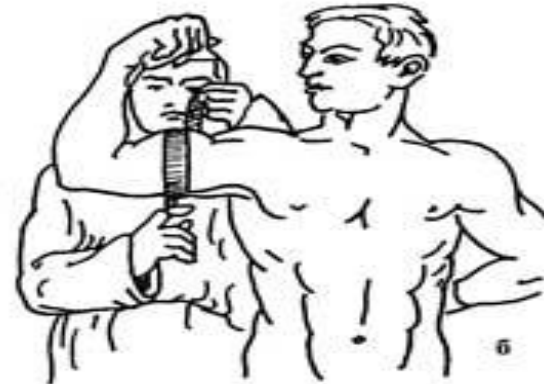
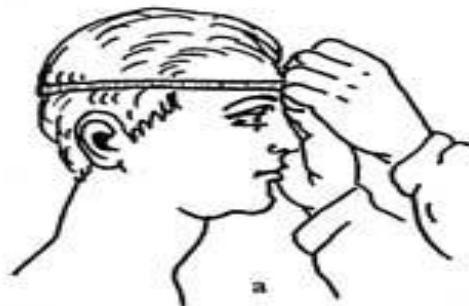
Измерение массы тела



Измерение окружности груди



Измерение окружностей



www.fiziolive.ru





Санитарная обработка больных

Санитарная обработка пациента



► Вид и показания определяет ВРАЧ!

Полная

- Гигиеническая ванна
- Душ



t° воды
36-37 ° C

Специальная

При выявлении
педикулеза



Частичная

- Обтирание
- Обмывание участков тела

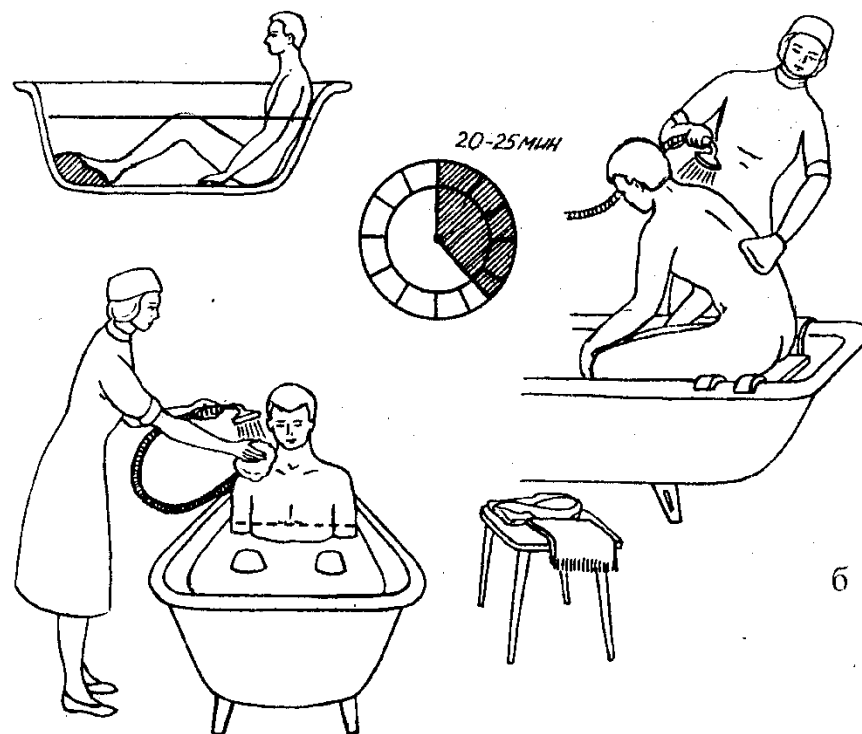


МЫТЬЕ ПАЦИЕНТА



- ▶ Мытье пациента может проводить младшая медицинская сестра или санитарка под наблюдением сестры.
- ▶ Присутствие медицинской сестры во время санитарной обработки пациента обязательно.

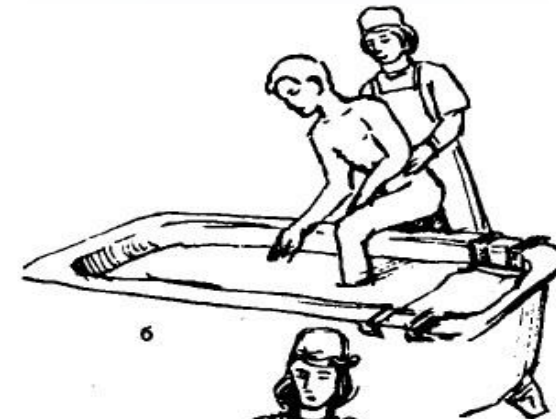
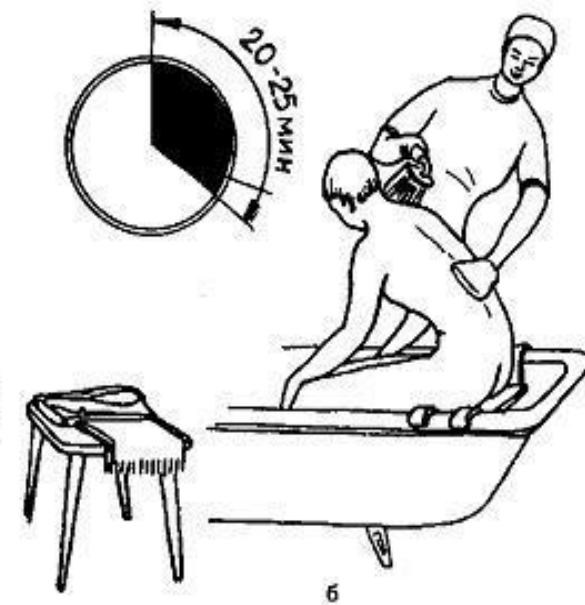
- ▶ При ухудшении состояния пациента (появление болей в области сердца, сердцебиение, головокружение, бледность кожных покровов и других признаках) следует прекратить гигиенические процедуры, немедленно сообщить дежурному врачу об ухудшении состояния пациента, оказать первую доврачебную помощь.



Полная гигиеническая обработка

Ванна, душ

- Температура воздуха в ванной комнате не менее 25 С.
- Температура воды 35-37С.
- Продолжительность не более 25 минут.
- Оснащение: непромокаемый фартук; индивидуальные: мыло, мочалка, шампунь, полотенце, чистое нательное, постельное белье, водяной термометр, подставка для ступни, для душа — специальное сидение.



Частичная гигиеническая обработка



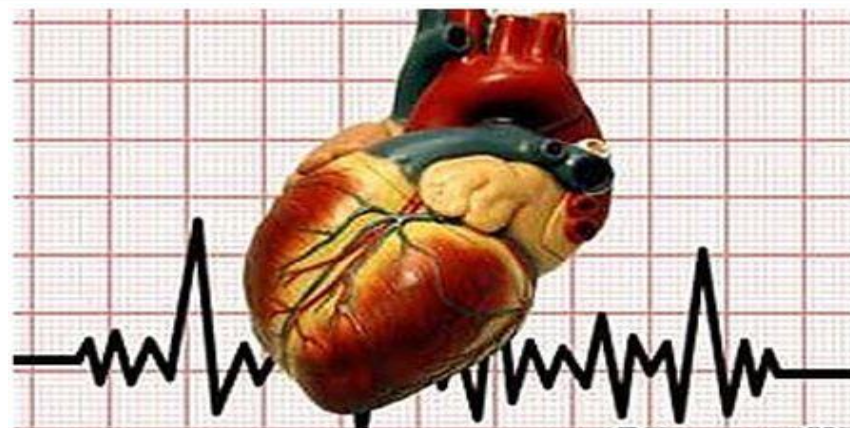
- ▶ Обтирание, обмывание
- ▶ Оснащение: таз, вода 36-37С, варежка индивидуальная, простынь, чистая одежда, мыло, перчатки, фартук.



Не разрешается принимать гигиеническую ванну больным с тяжелыми заболеваниями



- ▶ Гипертонический криз
- ▶ Декомпенсация сердечной недостаточности
- ▶ Острый инфаркт миокарда
- ▶ Острое нарушение мозгового кровообращения
- ▶ Активное кровотечение
- ▶ Туберкулез в активной фазе
- ▶ Политравма
- ▶ Заболевания, требующие незамедлительной операции
- ▶ Некоторые кожные заболевания
- ▶ Роженицы



Дезинфекция предметов медицинского назначения



- ▶ Ванна – 1% раствор хлорной извести, 0,5 гр. смеси на 100 см²
- ▶ Мочалка – кипячение в воде 30 мин.
- ▶ Полотенце – дезинфекция 3% раствор хлорамина на 60 мин.



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Осмотр пациента на паразитозы



Мероприятия при выявлении педикулеза



Педикулез, или вшивость – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Вши, паразитирующие на человеке

Платяные

Переносчики инфекционных заболеваний:
сыпного тифа, волынской лихорадки,
возвратного тифа

Головные

Лобковые

Эпидемиологичес-
кого значения не
имеют

Вне хозяина вши могут находиться

До 7 дней

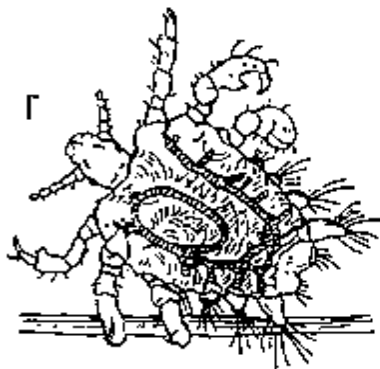
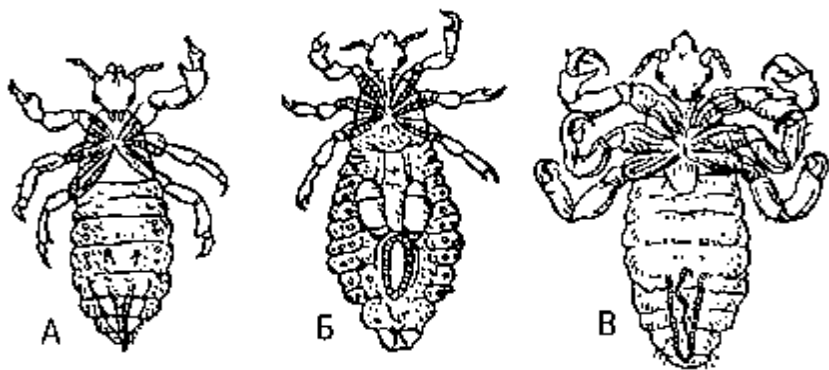
1 сутки

Несколько часов

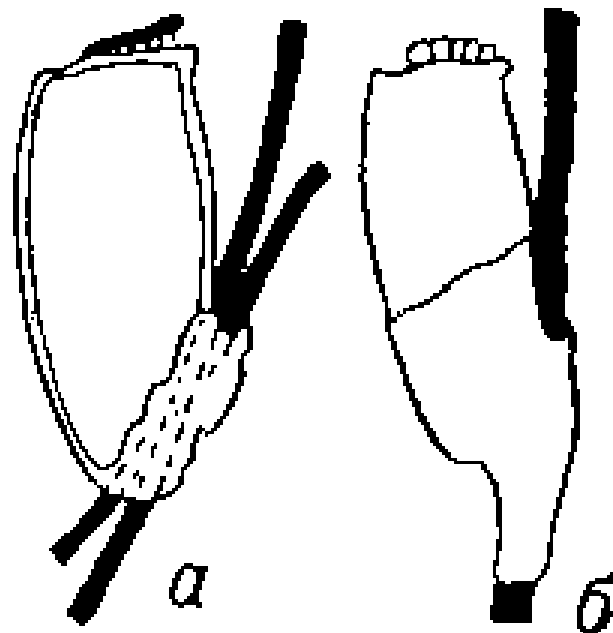
Виды вшей



- **головная** – поражает волосяной покров головы - предпочтительно на висках, затылке и темени;
- платяная** – поражает кожные покровы туловища;
- лобковая** – поражает волосистую поверхность лобковой области, волосяной покров подмышечных впадин и лица – усы, бороду, брови, ресницы.



- А – самец головной вши
Б – самка головной вши
В – самец платяной вши
Г – площица (самка).



а – гнида
платяной
вши

б – гнида
головной
вши.

Физиология вшей и гнид



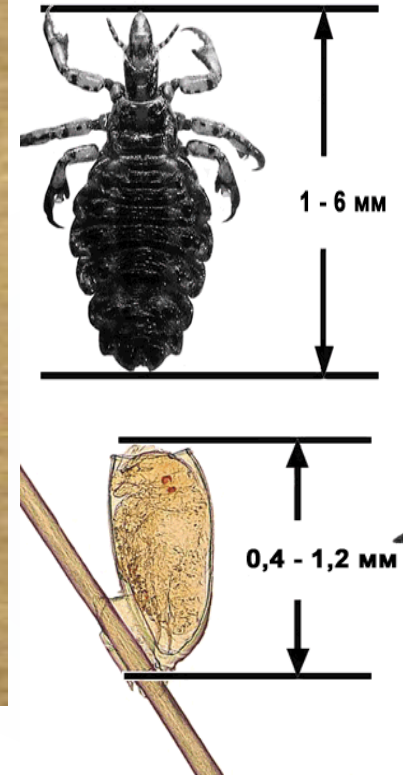
гнида
0

личинка
7-8

половозрелая особь
16-20

Жизненный цикл вши составляет 30 дней

В сутки самка вши откладывает 5-10 яиц





Жизненный цикл лобковой вши



1 яйцо

После спаривания самка откладывает яйца, приклеивая их к основанию волосу

Взрослая вошь живет 3-4 недели. Весь жизненный цикл проходит на хозяине.

При удалении с хозяина вошь погибает за 48 часов

В течение недели вылупляются нимфы и начинают сосать кровь носителя



2 нимфа в первой возрастной стадии



3 нимфа во второй возрастной стадии



4 нимфа в третьей возрастной стадии

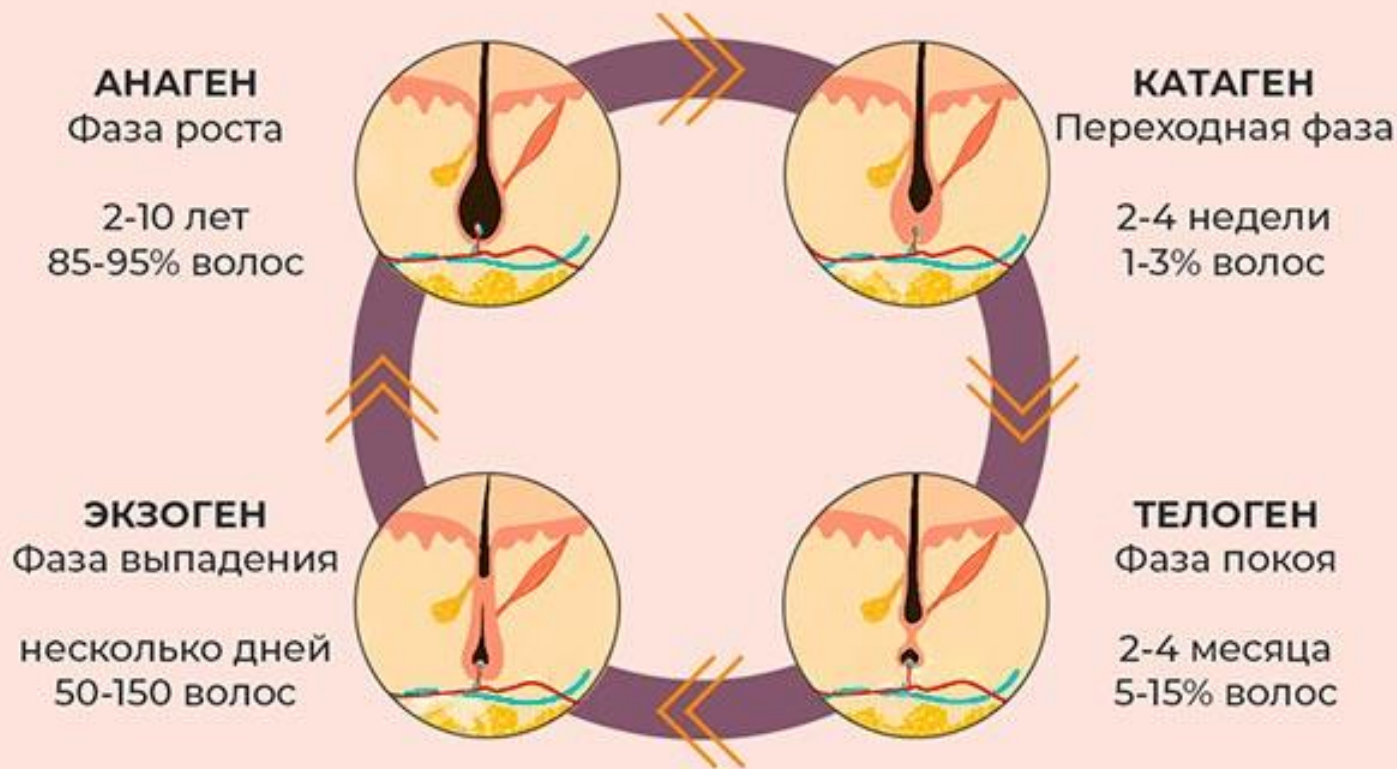
Вши передаются от человека к человеку в основном при половых контактах

В течение 13-17 дней нимфа проходит все три стадии развития и становится взрослой особью



5 имаго - взрослая вошь

ЦИКЛ РОСТА ВОЛОС



0,33 – 0,4 мм в сутки!

Источники заражения



- ▶ **Головные и платяные вши** передаются от человека к человеку при непосредственном контакте (либо через одежду, бельё, предметы обихода, расчёски и т. п.).
- ▶ **Лобковая вошь (площица)**, как правило, передаётся половым путём, но возможна также передача через вещи (постельное бельё, одежда и т. д.).
- ▶ **Платяные вши** располагаются в складках одежды, поражают человека в местах соприкосновения одежды с участками тела (участки между лопатками, шею, поясницу). В основном платяной педикулез распространен среди людей с плохими условиями жизни и гигиены.

Невозможно заразиться вшами от животных, так как эти паразиты видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке



Основные признаки педикулёза



- ▶ *зуд, сопровождающийся расчёсами, иногда аллергией,*
- ▶ *огрубление кожи от массовых укусов вшей и воздействия слюны насекомых на дерму,*
- ▶ *меланодермия – пигментация кожи за счёт кровоизлияния в ткани и воспалительного процесса, вызываемого воздействием слюны насекомых,*
- ▶ *колтун - образуется из-за расчесов головы. Волосы запутываются и склеиваются серозно-гнойными выделениями, засыхающими в корки, под которыми находится мокнущая поверхность. В настоящее время встречается редко.*





Wesz



Jajka wesz



Патогенез педикулеза (вшивости)



- ▶ Колющим хоботком насекомые погружаются в толщу кожи и сосут кровь. При этом в толщу кожи попадает секрет, обладающий выраженным раздражающим свойством. На месте укуса в дерме появляются очажки плотного воспалительного инфильтрата из полинуклеидов, лимфоцитов и в меньшей степени - эозинофилов. Течение воспалительного процесса характеризуется расширением сосудов и развитием отека кожи.
- ▶ В результате интенсивного зуда появляются точечные и местные расчесы, которые в последующем нередко осложняются пиодермией и экзематизируются.
- ▶ Нанося укус, вошь впрыскивает в ранку вещества, вызывающие зуд. Расчесывание мест укусов приводит к экзематизации кожи и присоединению вторичной инфекции.
- ▶ Зуд нарушает сон и вызывает невротические состояния, особенно у детей.



Запущенный педикулез



Симптомы фтириаза



Локализуются на коже лобка и пограничной с ним области бедер и живота, распространяются на кожу груди, подмышечных впадин, область бровей и ресниц. На месте укусов насекомых образуются круглые бледно-синие или бледно-серые пятна, не исчезающие при надавливании. У лиц с выраженным оволосением кожи лобковые вши могут быть на всем кожном покрове.



Площицы малоподвижны, прикрепляются к коже и основаниям волоса,, иногда в этих местах развивается воспалительная реакция в виде небольшого размера (до 1 см) синюшных с геморрагическим оттенком пятен (так называемые вшивые пятна). В запущенных случаях вшей находят на бровях и ресницах, куда они приклеивают свои гниды. В случае поражения ресниц возникает отек и воспаление век (паразитарный блефарит).



При обнаружения педикулеза



- ▶ 1. Заполнить экстренное извещение о выявлении инфекционного заболевания и сообщить в учреждение санэпиднадзора (форма № 058у),
- ▶ 2. Зарегистрировать данные о пациенте в «Журнале учета инфекционных заболеваний» (форма № 060у).
- ▶ 3. Делать отметку на титульном листе «Медицинской карты стационарного больного» сделать отметку о выявленном педикулезе: «Р» (лат. pediculus— вошь).

Р

Дата заболевания	Диагноз и дата установления	Измененный, уточненный диагноз и дата установления	Лабораторное обследование и результаты	Примечание
1.04.20г.	Острый аппендицит 1.04.20г.	Смешанный педикулез: гниды, насекомые 1.04.20г.	1.04.20г. Медифокс (супер) Педикулез не выявлен	

Противоэпидемические мероприятия



- ▶ противопаразитарную обработку у больного человека волос и кожи в пораженных областях;
- ▶ медицинский осмотр и обязательную противопаразитарную обработку контактных лиц (половые и бытовые контакты);
- ▶ санитарную обработку одежды, головных уборов, постельных принадлежностей, обивки мягкой мебели, полотенец, мочалок, мягких детских игрушек (стирка при температуре выше 80 °C, проглаживание утюгом с паром, обработка химическими акарицидными средствами).
- ▶ **Обработка педикулицидами детей до 5 лет, кормящих и беременных женщин, людей с поврежденной кожей (микротравмы, дерматиты, экзема и т. п.) запрещается**

Противопедикулезная укладка



- Дополнительный халат (лучше санитарный)
- Перчатки, бахилы (можно клеёнчатый фартук), маска.
- Салфетка и косынки (клеёнчатые или полиэтиленовые и матерчатые)
- Полотенце
- Кисточку или палочку с накрученным ватным тампоном
- Противопедикулезные препараты (например, Медифос, Педилин, Ниттифор, Рид, Пара Плюс и др.).
- Уксусная кислота (6%–8%)
- 70% спирт
- Частый гребень и лупу
- Препараты для дезинсекции помещений (Карбофос 0,15%)
- Ёмкость для сжигания волос
- Ёмкости для шампуней
- Два мешка полиэтиленовых

При средней и большой поражённости (от 10 экземпляров и более, включая насекомых и гнид) рекомендуется использовать ИНСЕКТИЦИДЫ-ПЕДИКУЛИЦИДЫ.



Педикуляцидное средство. Форма выпуска.	Назначение
ВАЛИТЕН – водно-спиртовой лосьон на основе сумитрина	Головной педикулез
СИФАКС – инсектицидный шампунь	Головной
АВИРОН (таблетка)	Головной, лобковый
ФЛОРОЦИД – водно-спиртовой лосьон	
НИТТИФОР – лосьон	
ЛАНЦИД -лосьон	
ГРИНЦИД - лосьон	
ПЕРФОЛОН - лосьон	Головной, лобковый
КАРБОФОС - лосьон	

Противопедикулезные мероприятия



I. Подготовка к процедуре

1. Надеть дополнительный халат, фартук, перчатки.
2. Объяснить пациенту необходимость и последовательность предстоящей процедуры и получить согласие на проведение.
3. Усадить пациента на стул, накрытый клеенкой (или постелить клеенку на пол и поставить на нее стул).
4. Дать в руки пациенту (если это возможно) полотенце, чтобы уберечь его глаза от попадания педикулицидного средства

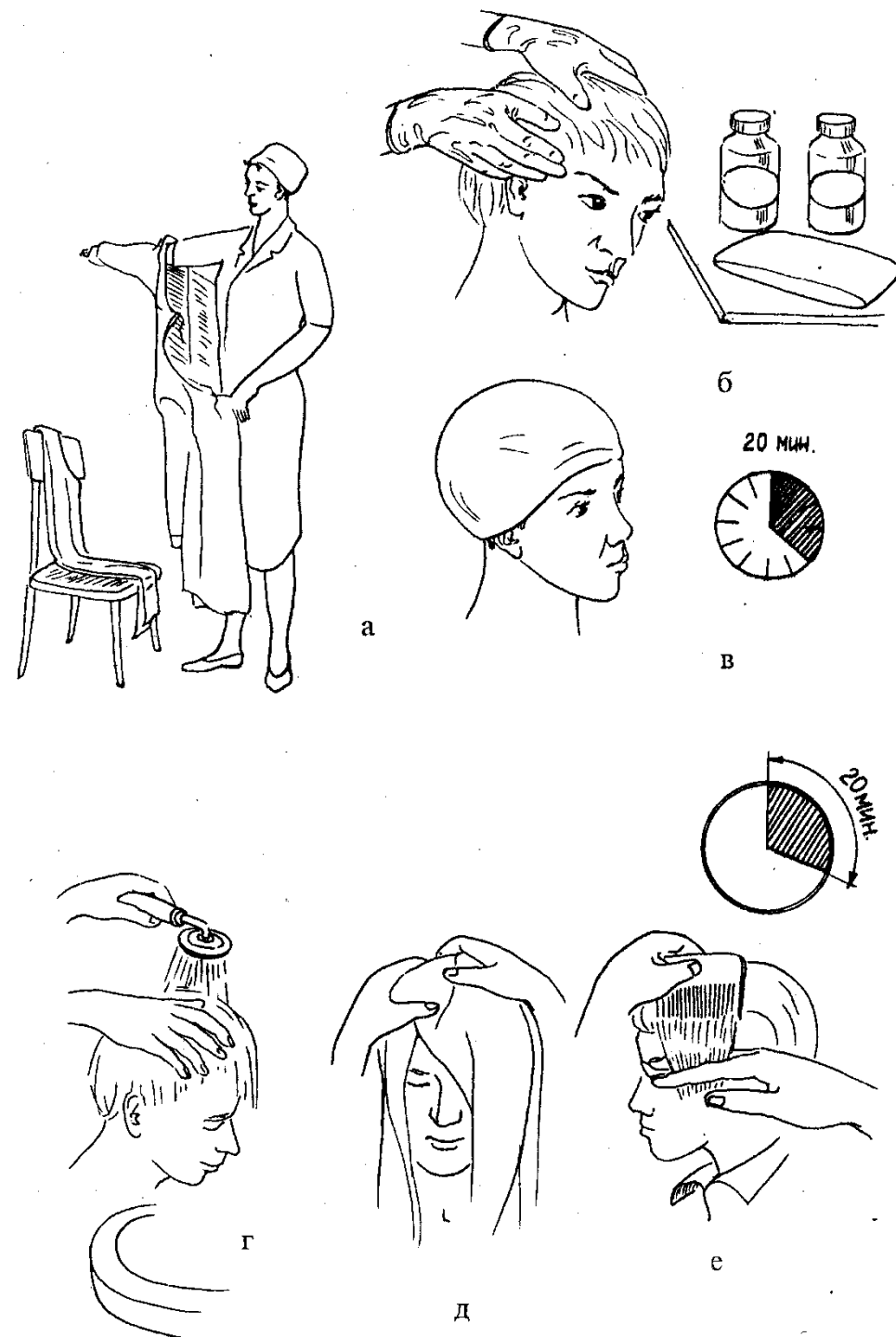
II. Выполнение процедуры

5. Обработать волосы пациента любым противопедикулицидным средством.
6. Покрыть волосы пациента шапочкой на 20 мин. (по некоторым технологиям шапочка не требуется)
7. Промыть волосы теплой водой, вытереть их.
8. Вычесать сухие волосы частым гребнем в течение 15—20 мин., разделяя волосы на пряди и последовательно вычесывая каждую прядь.

III. Завершение процедуры

9. Белье и одежду пациента сложить в мешки для дезинсекции.
10. Снять перчатки, фартук, халат (поместить в мешок для дезинсекции), вымыть руки.
11. На титульном листе «Медицинской карты стационарного больного» сделать отметку о выявленном педикулезе: «Р» (лат. pediculus — вошь).
12. Заполнить экстренное извещение о выявлении инфекционного заболевания и сообщить в учреждение санэпиднадзора (форма № 058у).
13. Осмотреть сухие волосы пациента.

После проведения дезинсекции пациента помещение и предметы, с которыми он контактировал, необходимо обработать теми же педикулицидными препаратами. Гребень обдают крутым кипятком после каждого осмотра, или протирают 70градусным раствором спирта.



При обнаружении лобковых вшей проводят санитарную обработку:



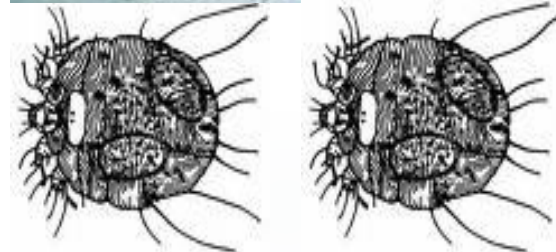
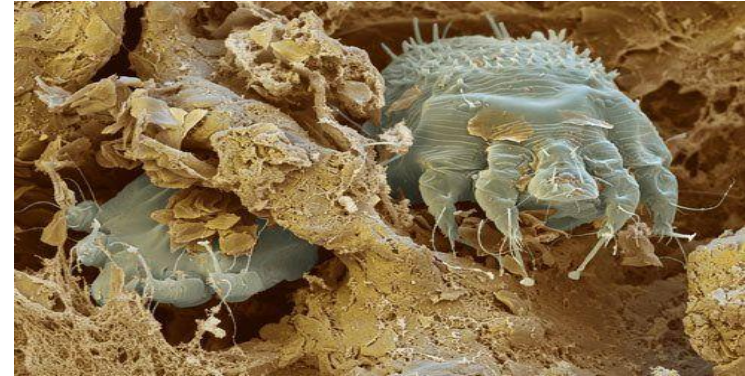
- полное мытье горячей водой с мылом и мочалкой с последующей сменой белья.
- В случае необходимости (с согласия пациента) сбривают ВОЛОСЫ.

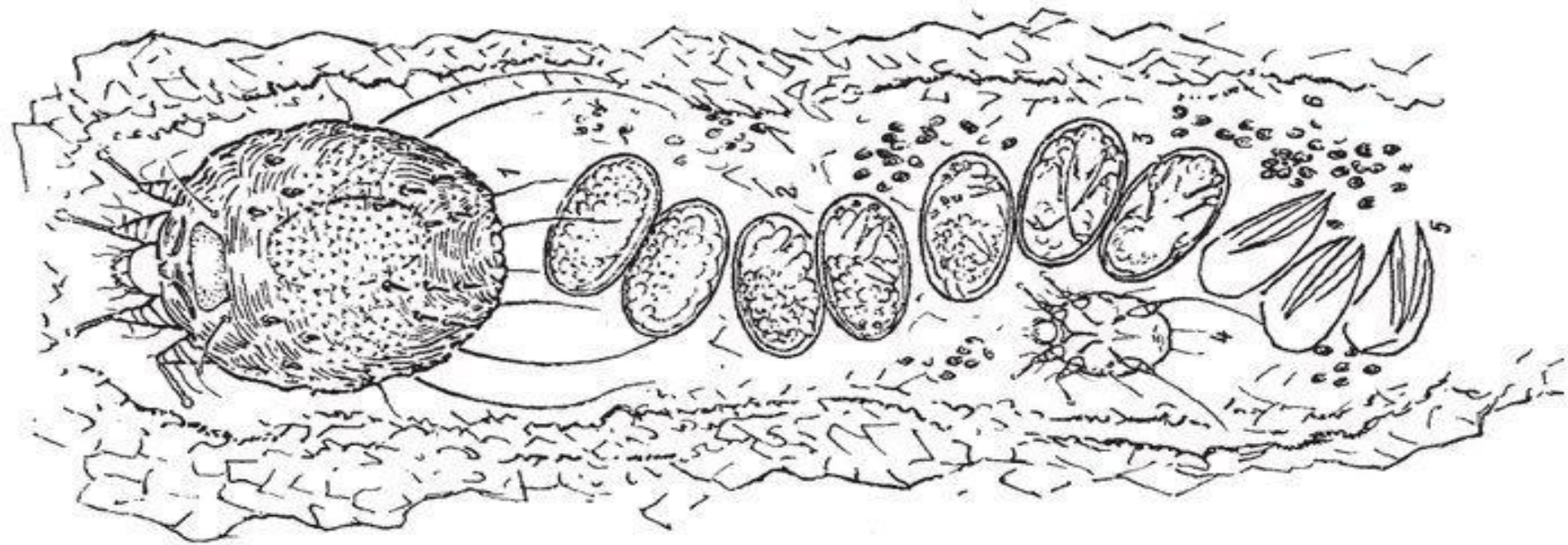
Чесотка



▶ **Чесотка (scabies)** - распространенное паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом *Sarcoptes scabiei*

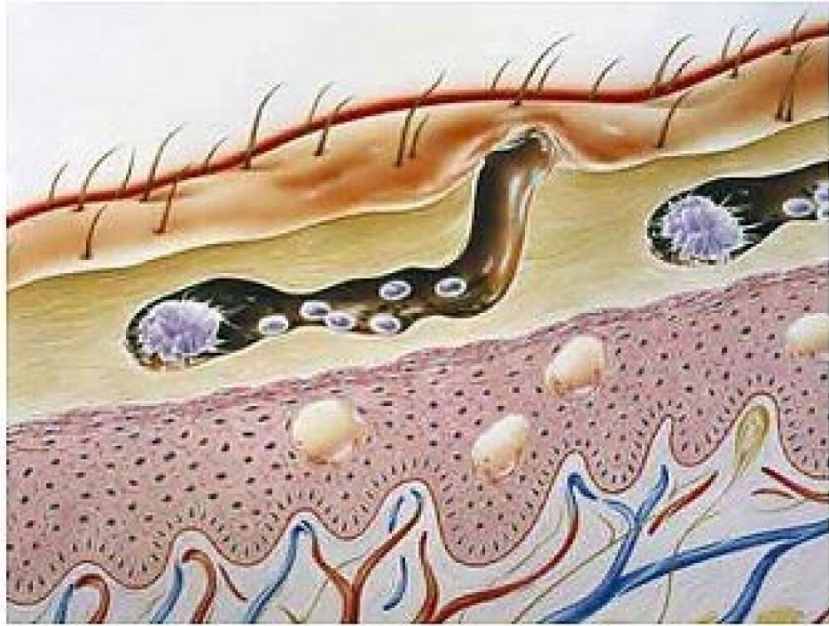
▶ **Псевдосаркоптоз** - заболевание, вызываемое у человека чесоточными клещами животных.



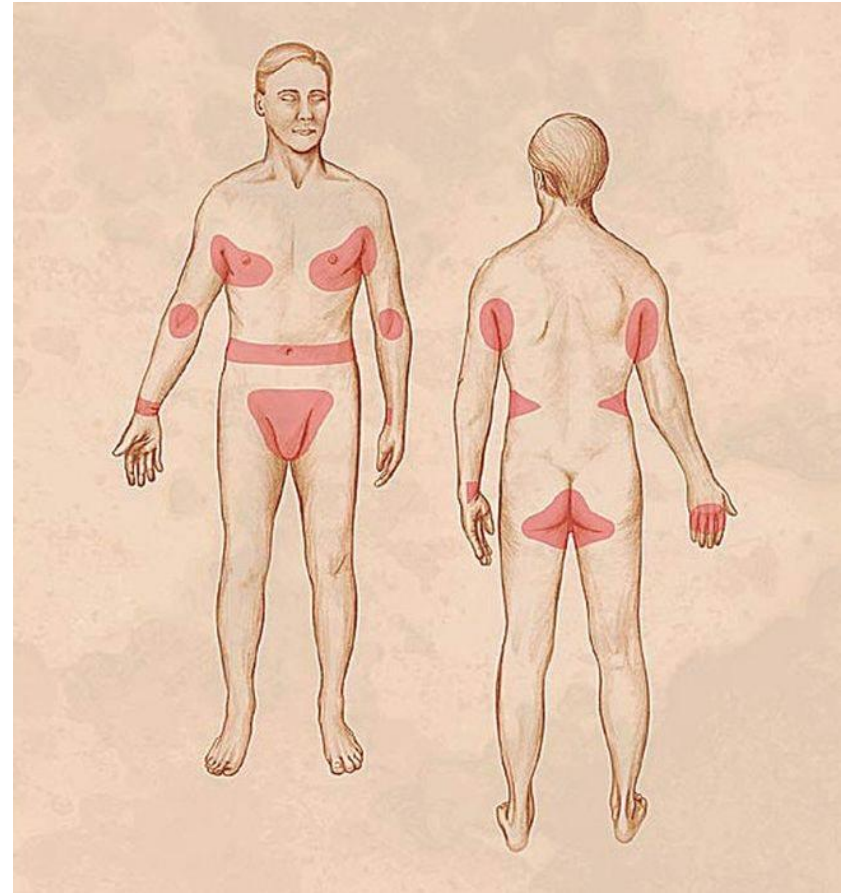


Утром и днем клещи неактивны. Самка клеща, живущая не более 4-6 недель, вечером и ночью со скоростью по 2-3 мм в сутки роет в эпидермисе чесоточный ход, в котором **ежедневно откладывает по 2-4 яйца**. Самцы формируют короткие боковые ответвления в чесоточном ходе самки. Клещи растворяют кератин кожи с помощью специальных протеолитических ферментов, содержащихся в слюне, и питаются образовавшимся лизатом (раствором). Ночью клещи выходят на поверхность кожи для спаривания и освоения новых территорий. Понятно, что легче всего заразиться чесоткой ночью в общей постели.

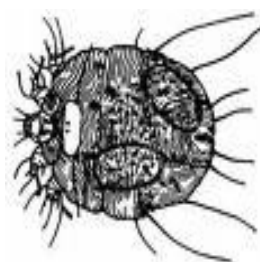
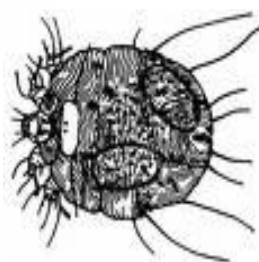
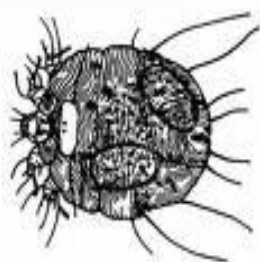
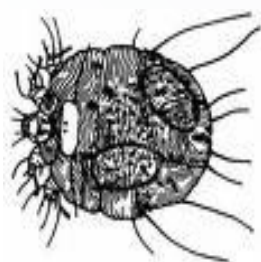
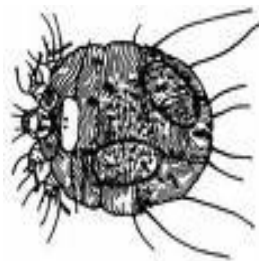
Основные признаки чесотки



- 1) Усиление зуда вечером и ночью.
- 2) Типичные места высыпаний.
- 3) Групповой характер зуда.







Узелковая (нодулярная) чесотка = скабиозная лимфоплазия



- ▶ Проявляется в виде немногочисленных зудящих круглых узелков(уплотнений) диаметром 2-20 мм красного, розового или коричневого цвета. На поверхности новых узелков можно обнаружить чесоточные ходы.
- ▶ Характерная локализация:
 - ▶ мошонка и пахово-мошоночные складки,
 - ▶ половой член,
 - ▶ внутренняя поверхность бедер и ягодицы,
 - ▶ подмышечные складки,
 - ▶ вокруг заднего прохода,
 - ▶ ареола.
- ▶ Узелки обычно немногочисленны. Иногда они являются единственным диагностическим признаком чесотки.





У детей –
протекает иначе!



СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний (от 28.01.2021, с изм. на 25.05.2022)



► 3371. При обнаружении чесотки у детей, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, престарелых, инвалидов, лиц, проживающих в общежитиях, членов многодетных семей, мигрантов, лиц без определенного места жительства **проводят обработку (в том числе нательного и постельного белья)** по заявкам организаций и лиц. Дезинфекционные обработки проводят организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

► 3373. Детей дошкольного и школьного возраста при обнаружении чесотки отстраняют от посещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на время проведения лечения. Допуск в организации, осуществляющие образовательную деятельность разрешается только после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей медицинской справкой.

3374. Врач с учетом эпидемиологической обстановки определяет необходимость профилактического лечения лиц, контактировавших с больным чесоткой. **Лечение проводят лицам, находившимся в контакте с больным, а также из организаций, где зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой или в процессе наблюдения за очагом (в течение 1 месяца) выявлены новые больные.** В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, где профилактическое лечение контактных лиц не проводилось, **осмотр кожных покровов обучающихся осуществляют трижды с интервалом в 10 календарных дней.**

► 3375. При выявлении в организации чесотки проводится текущая дезинфекция.

Лечение

специфическое / профилактическое / пробное



- ▶ **Специфическое лечение** проводится при наличии у больного чесотки, диагноз которой подтвержден клинически и лабораторно путем обнаружения возбудителя.\
- ▶ **Профилактическое лечение** проводится по эпидемиологическим показаниям в очагах чесотки лицам, у которых клинические проявления заболевания отсутствуют.
 1. Члены семейных очагов (родители, дети, бабушки, дедушки, прочие родственники), а также няни, гувернантки, сиделки;
 - при наличии условий для передачи возбудителя (тесный телесный контакт, половой контакт, совместное пребывание в постели в вечернее и ночное время и т.п.);
 - при наличии больных чесоткой детей младшей возрастной группы, с которыми обычно контактирует большинство членов семьи;
 - при выявлении в очаге двух и более больных (иррадиирующий очаг).
 2. Члены инвазионно-контактных коллективов:
 - лица, имеющие общие спальни, при наличии тесного телесного контакта с больным чесоткой;
 - все члены групп/классов/подразделений, где зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой или в процессе наблюдения за очагом выявляются новые больные.
- ▶ **Пробное лечение (ex juvantibus)** проводится только в тех случаях, когда врач по клиническим данным подозревает наличие чесотки, но диагноз не подтвержден обнаружением возбудителя.

Принципы терапии (основные)



- ▶ одновременное лечение всех больных, выявленных в очаге, для предотвращения реинвазии;
- ▶ нанесение противочесоточных препаратов в вечернее время для повышения эффективности терапии, что связано с ночной активностью возбудителя;
- ▶ нанесение противочесоточных препаратов, разрешенных к применению у детей в возрасте до 3 лет на весь кожный покров, у остальных больных исключение составляют лицо и волосистая часть головы;
- ▶ нанесение скабицидов голыми руками, а не салфеткой или тампоном, особенно тщательно препараты втирают в кожу ладоней и подошв;
- ▶ проведение мытья перед первым нанесением скабицида и после завершения лечения;
- ▶ смена нательного и постельного белья – после курса терапии;
- ▶ экспозиция препарата на коже должна быть не менее 12 часов, включая весь ночной период, утром его можно смыть;
- ▶ проведение лечения осложнений одновременно с лечением чесотки;
- ▶ после завершения терапии необходимо провести дезинсекцию нательного и постельного белья, полотенец, одежды и обуви, провести влажную уборку в помещении, где находился больной.

Схемы лечения



Перметрин 5% концентрат эмульсии в этаноле

Эмульсия и мазь бензилбензоата

- препараты на основе бензилового эфира бензойной кислоты
- Для детей в возрасте от 3 до 7 лет применяют 10% эмульсию и мазь, для лиц старших возрастных групп – 20% эмульсию и мазь бензилбензоата

- Водная 0,4% эмульсия готовится *ex tempore* путем разбавления 8 мл 5% концентрата эмульсии перметрина водой комнатной температуры до объема 100 мл.
- Втирание препарата проводится 1 раз в день на ночь 3 дня подряд или в 1-ый и 4-ый дни курса.
- Не рекомендуется при лактации, детям в возрасте до 1 года, пожилым людям с недостаточностью функции печени, почек.

Серная мазь

- препарат на основе осажженной серы (33% серы)
Серная мазь наносится на кожу после мытья с мылом 1 раз в день на ночь в течение 5–7 дней.
- Не рекомендуется применять во время беременности и детям до 3 лет.

Для лечения детей в возрасте до 1 года применяют аэрозоль для наружного применения пиперонилбутоксид + эсбиол; для лечения детей в возрасте от 1 года до 3 лет – аэрозоль для наружного применения пиперонилбутоксид + эсбиол и 5% концентрат эмульсии перметрина в этаноле; для лечения детей в возрасте от 3 до 7 лет – к указанным средствам добавляется 10% эмульсия и мазь бензилбензоата, 5% серная мазь; терапия детей в возрасте старше 7 лет проводится по схемам лечения взрослых лиц.



Идентификация пациентов

Показания для идентификации



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 июля 2020 года N 785н

Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

- ▶ при обращении за медицинской помощью (регистратура, приемное отделение);
- ▶ перед осмотром пациента, выполнением процедуры;
- ▶ перед переводом пациента в другое отделение или в другую палату;
- ▶ перед назначением пациенту лекарственных препаратов и их введением (применением);
- ▶ перед переливанием донорской крови;
- ▶ перед забором крови и других биоматериалов для анализов;
- ▶ перед проведением оперативных вмешательств и инвазивных процедур;
- ▶ перед перевязкой;
- ▶ перед кормлением младенца и выдачей продуктов специализированного и лечебного питания;
- ▶ перед применением инструментальных методов исследования

Виды идентификации



► В сознании, с документами, с сопровождением

Поприветствовать.

Устно идентифицировать пациента.

Сравнить полученные сведения с информацией в паспорте, свидетельстве о рождении или страховом медицинском полисе.

► Без сознания, с документами и сопровождающими

Поприветствовать.

Спросить у сопровождающих Ф. И. О., дату рождения и адрес проживания пациента.

Сравнить полученные сведения с информацией в паспорте, свидетельстве о рождении или страховом медицинском полисе.

► Без сознания, без документов и сопровождающих

Присвоить литер «неизвестный» с порядковым номером.

Отправить сообщение с подробным описанием пациента в ближайший полицейский участок.

Отметить в журнале время отправки и Ф. И. О. принявшего и передавшего сообщение

Алгоритм идентификации



- ▶ **ФИО**
- ▶ **Дата рождения (полностью)**
- ▶ **Отделение**
- ▶ **Сбор информации осуществляется открытыми вопросами (Как Вас зовут, Ваша дата рождения?)**
- ▶ **При выполнении анализа крови на ВИЧ (ф-50) обязательно сверить данные пациента с паспортом / свидетельством о рождении!**



Белый –
всем пациентам
Желтый –
высокий риск
падения
Красный –
аллергия
(подозрение)





Транспортировка в профильное отделение



БОЛЬНОЙ

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ
(способный перенести перевозку)

НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ

Состояние
относительно
удовлетворительное

Тяжелобольной

Больной идёт пешком
/ на руках в
сопровождении среднего
или младшего
медицинского
персонала

Носилки, каталка,
кресло-каталка

Медицинскую помощь
оказывают на месте,
затем больного
переводят в
реанимационное
отделение

Перемещение на кресле-каталке



- ▶ Проводится одним медицинским работником.
- ▶ Последовательность действий:
- ▶ Проверить исправность кресла-каталки, подготовить его к работе.
- ▶ Наклонить кресло-каталку вперед, наступив на подставку для ног.
- ▶ Попросить пациента встать на эту подставку и усадить его в кресло, поддерживая под спину.
- ▶ Привести кресло-каталку в исходное положение.
- ▶ Придать пациенту необходимое положение (сидя либо полулежа) с помощью рамки, располагающейся за спинкой кресла.
- ▶ Накрыть пациента одеялом или простыней.
- ▶ Контролировать положение рук пациента — чтобы
- ▶ они не выходили за пределы подлокотников во время
- ▶ транспортировки.
- ▶ По прибытии к месту назначения помочь пациенту
- ▶ пересесть на кровать в палате.





Транспортировка на каталке



- ▶ Проводится тремя медицинскими работниками.
- ▶ Последовательность действий и безопасность:
- ▶ Проверить на исправность и подготовить к транспортировке каталку.
- ▶ Постелить на каталку одеяло, чтобы его половина (по вертикали) оставалась свободной. Накрыть одеяло простыней, положить подушку.
- ▶ Поставить каталку под прямым углом ножной частью к изголовью кровати или кушетки.
- ▶ Приподнять пациента — один медработник подводит руки под шею и верхнюю часть туловища, другой — под поясницу, третий — под бедра и голени.
- ▶ Поднять пациента, повернуться с ним на 90 градусов и уложить его на каталку.
- ▶ Укрыть пациента свободным концом (половиной) одеяла с простыней.
- ▶ Один медицинский работник становится впереди каталки, другой — сзади, лицом к пациенту.
- ▶ Транспортировку пациента на каталке проводят головным концом вперед.





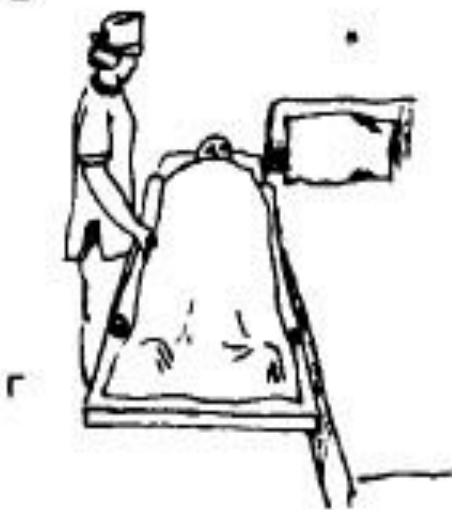
а



б



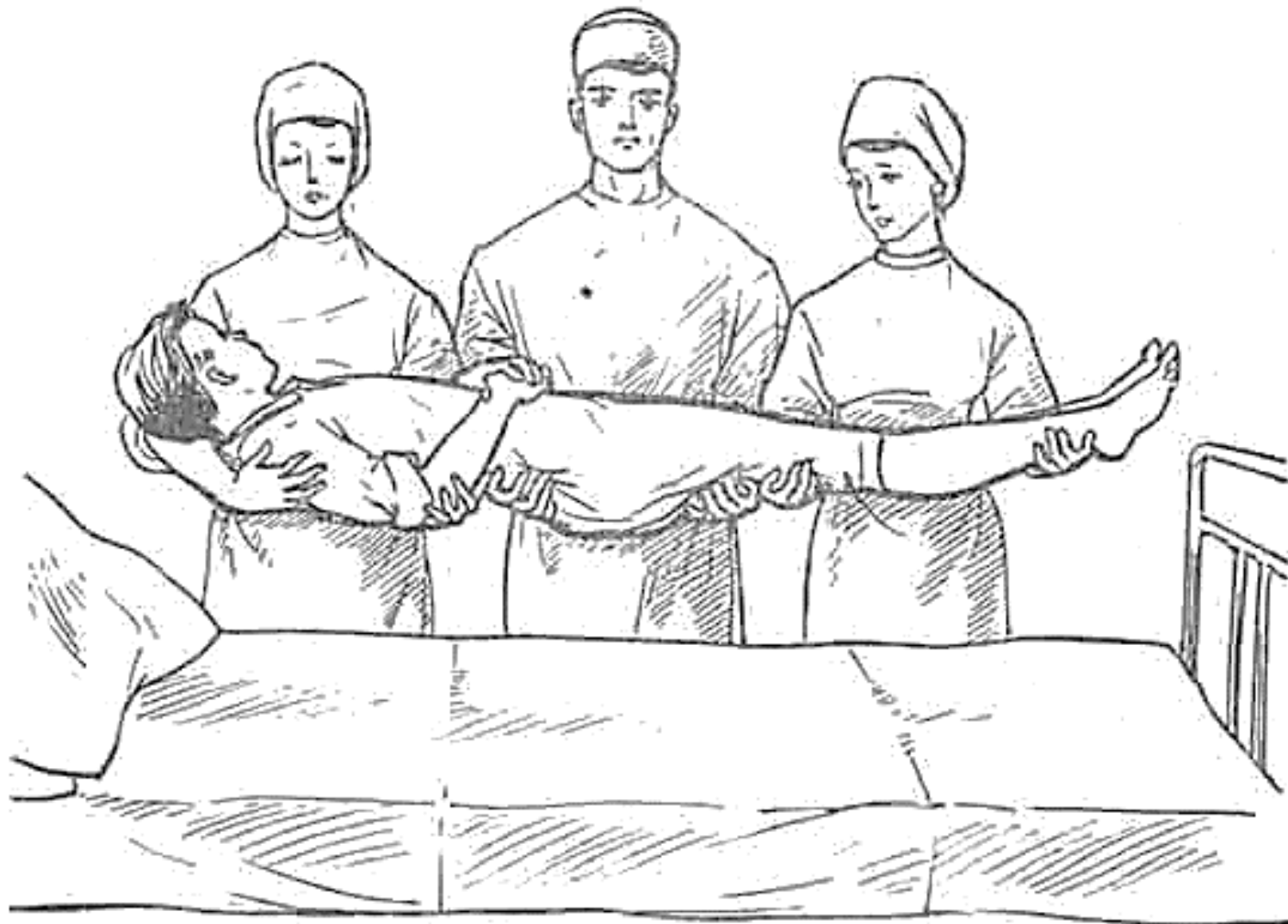
в



г



д



Транспортировка на носилках



- ▶ Проводится двумя медицинскими работниками.
- ▶ Последовательность действий и правила безопасности:
- ▶ Проинформировать пациента о ходе предстоящей ему транспортировки.
- ▶ Уложить пациента на носилки головой по направлению в сторону движения.
- ▶ Поднимать и опускать носилки двум медработникам следует синхронно, оставляя носилки в горизонтальном положении, на одинаковой высоте головного и ножного конца.
- ▶ Нести пациента следует головой вперед, аккуратно, без тряски, не раскачивая носилки, делая короткие шаги не в ногу.
- ▶ Медицинскому работнику, идущему сзади, следует наблюдать за состоянием пациента, спрашивать у него о самочувствии.
- ▶ При подъеме по лестнице носилки нужно нести головным концом вперед, приподнимая ножной конец и оставляя носилки в горизонтальном положении.
- ▶ При спуске по лестнице нести носилки ножным концом вперед, так же приподнимая ножной конец носилок.
- ▶ Если кто-либо из персонала устал, об этом сразу же следует сообщить остальным участникам транспортировки, затем остановиться и опустить носилки. Если не сказать об усталости, пальцы медицинского работника могут расслабиться и выпустить ручки носилок, следствием может стать падение пациента вместе с носилками.





AVI

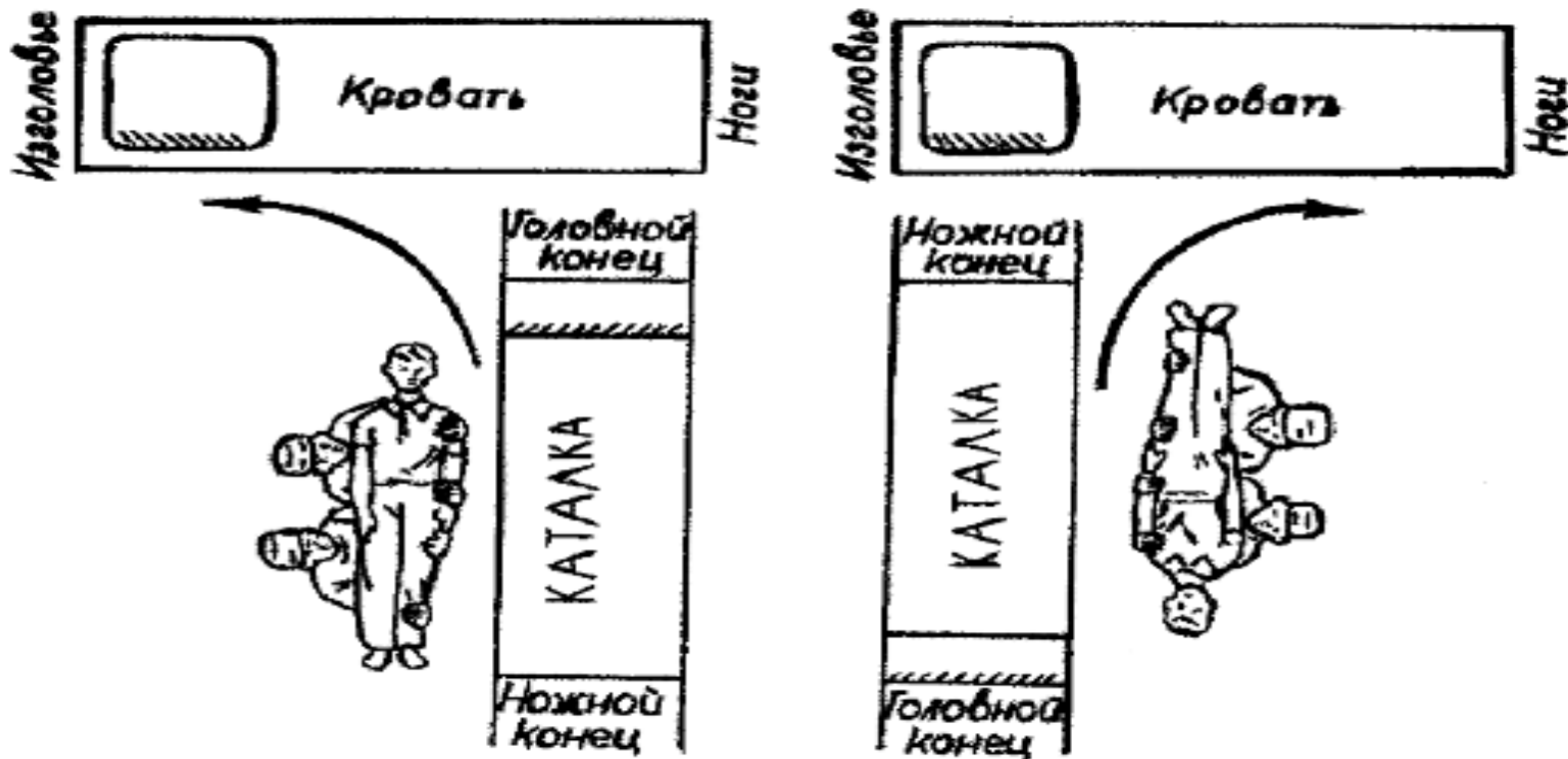


Особенности транспортировки пациентов в зависимости от заболевания



- ▶ Пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и кровоизлияниями в мозг транспортируют в положении лежа на спине.
- ▶ При бессознательном состоянии пациента его голову пациента следует повернуть набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.
- ▶ При сердечно-сосудистой недостаточностью пациентам придают полусидячее положение, т.к. из-за выраженной одышки, возможного отека легких они не могут лежать. Такие пациенты особо чувствительны к холоду, поэтому их необходимо укрывать, прикладывать к ногам и рукам грелки.
- ▶ Пациентов с острой сосудистой недостаточностью следует укладывать так, чтобы головной конец был ниже ножного.
- ▶ Тяжелобольным пациентам требуется очень осторожная транспортировка, а также аккуратный перенос с каталки на кровать. Следует заранее продумать, как поместить каталку относительно кровати при перекладывании пациента, чтобы избежать лишних и ненужных движений.

Перекладывание пациента



Каталку следует ставить параллельно кровати так, чтобы ее головной конец располагался к ножному концу кровати. Медперсонал становится между каталкой (носилками) и кроватью лицом к пациенту, вдвоем либо втроем поднимают пациента, и, повернувшись на 180 градусов, укладывают его на кровать.

Для удобства переноски пациента каталку можно ставить по отношению к кровати под прямым углом, последовательно (головным концом к ножному) и вплотную (головным концом к головному).

Транспортировка пациента в критическом состоянии



Приложение Б1. Алгоритм оценки риска транспортировки пациента в критическом состоянии

Модифицированная шкала ранней оценки систем (Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) (2007) Guidelines on the Use of Physiological Early Warning Systems. Clinical Resource Efficiency Support Team – Northern Ireland.)

Балл	3	2	1	0	1	2	3
ЧСС		<40	40-50	51-100	101-110	111-129	>130
АД сист	<70	71-80	81-100	101-170	171-199	>200	
ЧД		<7		9-14	19-22	23-29	>30
Температура		<34,9		35,0-38,3		>38,4	
ЦНС		Вновь возникшее возбуждение или оглушение		Спокойный пациент	Разговорчивый	Боль	Неконтактный

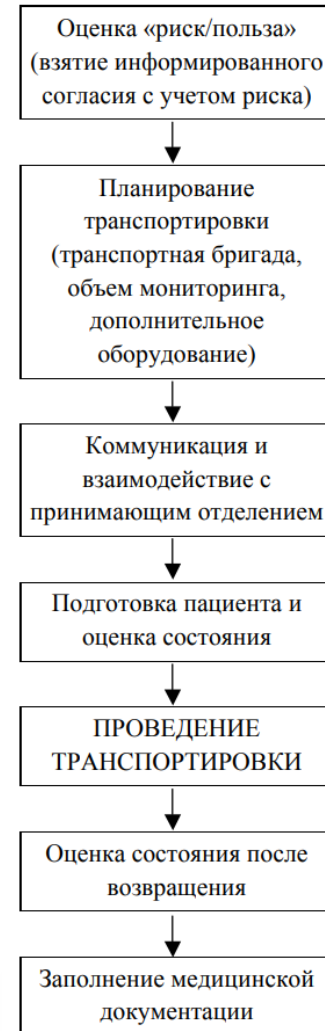
Стратификация риска ВГТ

Показатель	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Шкала ранней оценки, баллов <i>и/или</i>	Менее 3	3–5	Более 5
Сатурация, % <i>и/или</i>	> 92	88–92 или	< 88
ШКГ, баллов <i>и/или</i>	ШКГ > 13	13–12	< 12
ВЕ, ммоль/л	< 5	–5 ... –10	Менее –10

Группа низкого риска: низкая степень риска ухудшения состояния в ходе ВГТ.

Группа среднего риска: группа требует более детального планирования ВГТ.

Группа высокого риска: группа требует привлечения дополнительного оборудования, специалистов и оценки риск/польза в отношении решения выполнить ВГТ.



ПРОТОКОЛ ВНУТРИГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОТОКОЛ

транспортировки тяжелого пациента внутри медицинского учреждения
(кодový номер А14.30.002)



1. ФИО пациента _____
2. ФИО врача (ей) _____
3. Медицинская карта № _____
4. Название отделения _____
5. Дата, время: ____ / ____ / 20__ года.
Начало _____. Окончание ____: _____. Длительность _____ мин.
6. Показания к транспортировке:

1. Потребность в проведении диагностических манипуляций _____
_____;

Указать, каких именно

2. Потребность в проведении лечебных манипуляций _____

Указать, каких именно

3. проведение транспортировки с целью перевода в другое отделение _____

Указать, какое именно

7. Место назначения: операционная, рентгенооперационная; палата реанимации и интенсивной терапии; прочее _____

Указать, какое именно

8. Способ транспортировки: 1 – на каталке, 2 – на функциональной кровати;
3 – с использованием автомобильного транспорта.

9. Состояние до проведения транспортировки: _____.

Показатели газообмена _____, показатели гемодинамики _____,
неврологический статус _____.

10. Проводимый мониторинг: _____.

11. Состояние после проведения транспортировки: _____.

Показатели газообмена _____, показатели гемодинамики _____,
неврологический статус _____.

Критические инциденты / осложнения во время выполнения
транспортировки и предпринятые действия: 1 – не выявлено. 2 – сложности /
осложнения (описать): _____

16 Предприняты следующие действия: _____

ФИО врача _____ подпись _____

